

pr Narjis 1

Le cours que nous allons entamer aujourd'hui s'intitule les pans créatiques aiglées. Ce cours fait partie du module logique du geste physiologique des cynos. Nous allons commencer par une séance de révision Vous avez déjà eu le support Powerpoint des 4 cours qu'on a déjà fait Pour rappel, c'était le cours de la pathologie hernière au début, puis les pans créatiques aiguës, les tumeurs dévoilées et les tumeurs hépatiques.

Comme la séance d'aujourd'hui, nous avons à peu près 1h30, 90 minutes. Nous allons essayer de la partager en 4 parties. 20 minutes pour chaque cours.

Je pense que ce sera la bonne technique. On posera des questions par rapport à chaque chapitre. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer des messages, je les verrai en direct.

Au fur et à mesure, je vais essayer de reprendre le cours avec vous progressivement. Si il y a des questions à poser, je vous répondrai directement par le son. L'enregistrement est en cours par rapport à la question qui a été posée.

On va commencer par la pathologie hernière, qui est la première pathologie qu'on va voir en son premier cours. Donc, pathologie hernière de l'adulte. Par rapport à la pathologie hernière, on est en train d'y aller doucement.

Donc, pathologie hernière abdominale. On est en train de s'adapter. Excusez-moi, c'est la première fois qu'on utilise ça.

Donc, l'introduction, j'espère que vous allez arriver à suivre. Le but, ce n'est pas de reprendre tout le cours. On ne va pas reprendre tout le cours.

On va reprendre les points essentiels dans le cours, les points qui vous posent problème. Donc, au fur et à mesure, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que je n'ai que 20 minutes par cours. Ce qui n'est pas évident pour des cours qui sont parfois assez lents.

On va essayer d'insister sur les points qui me paraissent importants. Parce que vous avez déjà eu le support dans un premier temps. Et si vous avez des choses qui ne sont pas évidentes, qui ne sont pas claires, vous envoyez un message et je répondrai au fur et à mesure.

En introduction, la hernie, bien sûr, ça vous l'avez déjà eu en cours de sémiologie. C'est un sac à travers un orifice de la paroi abdominale. L'orifice, soit qu'il est naturel, soit qu'il a été provoqué par une intervention chirurgicale.

C'est ce qu'on appelle une éventration, une hernie incisionnelle ou hernie post-opératoire. C'est une pathologie qui est très fréquente. Le plus souvent, elle est bénigne.

Parfois, des complications qui sont graves, comme on l'a vu dans le cours que je vous ai laissé.

Le traitement, c'est une notion qui est extrêmement importante. À chaque fois que vous avez une hernie, il n'y a pas de traitement médical pour la hernie.

Hernie égal traitement chirurgical. Il n'y a que la chirurgie qui peut régler de façon définitive un problème. L'introduction est très importante.

Ensuite, alors, diapo suivante, ça, c'est le plan qu'on va suivre. On va aller un petit peu vite parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Déjà, par rapport au rappel anatomique.

Bon, là, vous êtes censé déjà la connaître, je suppose. Je ne vais pas trop insister dessus. Juste pour rappel, vous avez les deux grandes colonnes de la peau abdominale.

Ce sont les deux muscles grands droits qui s'étendent des dernières côtes qui vont vers le pubis. Ce qu'on appelle les deux muscles grands droits qui sont constants. Vous avez le pyramide de l'abdomen qui est un constant.

Et puis, en latéral, vous avez ce qu'on appelle les muscles larges. Les muscles larges qui sont divisés grossièrement en trois plans. L'oblique externe, l'oblique interne, les muscles transverses.

Plus en profondeur, vous avez le péritoine. Ce sont des notions de base que vous connaissez déjà. Je ne vais pas trop insister dessus.

Ce n'est pas le but du cours. Vous ne serez pas interrogé par rapport à ça. Mais vous êtes censé connaître ça parce que c'est comme vous le savez déjà, je suppose en chirurgie.

À chaque fois qu'on veut aborder une question chirurgicale, l'anatomie est la base. L'anatomie permet de résoudre pas mal de problèmes, de comprendre pas mal de choses en chirurgie. Voilà.

Donc ici, c'est une coupe chez un patient qu'on a pris. Ça rejoint ce qu'on a dit. Et l'intérêt de cette coupe, c'est qu'elle montre un petit peu déjà ce qu'on appelle des petites zones de faiblesse.

Vous avez les deux muscles grands droits de l'abdomen qui sont sur la partie médiane. Vous avez la coupe qui montre clairement les trois muscles obliques. Enfin, trois muscles larges, pardon.

Muscles obliques externes, obliques internes, muscles transverses. Et puis, vous remarquez déjà qu'il y a quelques petites zones de fragilité. Vous avez la ligne blanche abdominale au milieu.

Vous avez la ligne de Spiegel vers l'extérieur. Donc, ce sont des zones de fragilité. Ici, on est déjà sur les hernies.

Le principal hernie que vous êtes censé connaître, vous avez l'hernie épigastrique ou hernie de la ligne blanche. Si vous avez déjà vu, si vous voyez sur Internet ou sur d'autres références, on

peut également l'appeler hernie de la ligne blanche. C'est la hernie épigastrique.

Vous avez la hernie ombilicale au niveau de la région ombilicale. Vous avez une hernie incisionnelle. On suppose que là, c'est une incision que le patient a eue en latérale.

Souvent, ce n'est pas un appendicite. Vous avez la hernie de Spiegel qui est sur le bord externe du muscle grand droit. Et puis, vous avez les fameuses hernies de la région de l'aîne, comprenant notamment les hernies inguinales et les hernies fémorales ou hernies crurales.

Hernie fémorale ou crurale, c'est strictement la même chose. Donc, j'essaie d'aller un petit peu vite. Je m'excuse, je suis rapide parce que là, le but, ce n'est pas de faire le cours.

C'est de vous faire un petit peu avancer par rapport aux notions essentielles qui pourront vous servir secondairement pour comprendre le cours. On n'a malheureusement pas le temps de passer en revue tout le cours. J'essaie d'avancer.

Et si vous avez des interrogations, j'attends vos questions. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est une séance interactive.

Et donc, je suis là pour répondre aux choses qui vous paraissent un petit peu en bug. Donc, classification importante. Deux grands types de hernie.

Vous avez les hernies constitutionnelles. Les hernies qui sont dues à la présence d'un orifice, d'un sac herniaire au niveau d'un orifice naturel qui est déjà présent chez l'individu sans aucune intervention, sans aucune intervention chirurgicale. Ce qu'on appelle une hernie constitutionnelle.

Une hernie constitutionnelle à travers un orifice naturel. Donc, si je vous pose la question, qu'est-ce qui définit une hernie constitutionnelle? C'est une hernie à travers un orifice naturel. Par exemple, la hernie ombilicale est une hernie qui est naturelle, qui est constitutionnelle.

La hernie de la ligne blanche également est une hernie constitutionnelle. Par rapport à une hernie qui est acquise. Une hernie qui est acquise est une hernie postopératoire.

Donc, vous avez un patient qui a eu une intervention chirurgicale antérieure. Et puis, par rapport à cette intervention chirurgicale, il a développé une hernie postopératoire. On l'appelle également éventration postopératoire ou hernie incisionnelle.

C'est la même chose. Voilà. Donc, j'essaie d'avancer parce qu'on a quatre cours, comme j'ai dit.

Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance par rapport à ça. Donc, ça, ce sont les principales hernies constitutionnelles.

Les hernies de l'aine, comprenant les hernies inguinales et crurales. Les hernies ou hernies ombilicales. Les hernies de la ligne blanche ou hernies épigastriques.

Et puis, vous avez les raretés. Vous êtes en troisième année. On ne va pas s'amuser à vous citer tous les types de hernies qui existent.

Parce qu'il y en a une vingtaine, une trentaine, même plus, qui sont constitutionnelles. Ce n'est pas le but du cours. Voilà donc un schéma pour résumer ce qu'on vient de citer.

Hernie épigastrique entre l'ombilique et le sternum. Hernie ombilicale sur la région périombilicale ou lombrile. C'est la même chose.

Et puis, les hernies de l'aine inguinales et crurales. Les postopératoires, ce sont des éventrations. Donc, c'est une intervention chirurgicale antérieure qui a provoqué la hernie, qui a provoqué l'éventration.

Elles peuvent être réduites soit une cicatrice de l'apparotomie. L'apparot, c'est pour l'abdomen et l'omphalotomie, c'est pour ouvrir, ouvrir l'abdomen. Et l'aparoscopie, ce sont les nouvelles techniques chirurgicales.

Il y a une petite caméra qu'on introduit pour pouvoir un petit peu avoir l'orifice d'une hernie. Une question. On me demande, est-ce que pour avoir une hernie, est-ce nécessaire d'avoir une perforation du péritoine? Ou bien peut survenir par sa dilatation sans perforation? Non, il n'y a pas de perforation du péritoine.

Le péritoine reste intact, en fait. Le péritoine, il est intact. Et puis, c'est un sac péritonien qui va sortir.

C'est un orifice à travers les muscles de la paroi abdominale, en fait. Vous avez les muscles qui sont faibles, qui vont créer un orifice. Et à travers cet orifice-là, vous allez avoir un sac péritonien.

Le péritoine, il est intact. Parce que si le péritoine, il est rompu, vous allez sentir les ongles directement. Et là, c'est un risque énorme.

Non, il n'y a pas de perforation du péritoine. Le péritoine peut se perforer secondairement lorsqu'on a une complication. Lorsqu'on a une souffrance du sac péritonien, ça, on va le voir.

On peut le voir par la suite lorsqu'on verra les complications. Mais non, le sac péritonien, il est intact. Lorsqu'on a une hernie.

Donc, la parotomie et la paroscopie pour les démonstrations post-opératoires. Ici, c'est juste à titre indicatif. Comme je l'ai dit, toutes les incisions possibles.

Il y en a des centaines. Chaque chirurgien a son incision, lui, qui peut porter son nom. Il y a l'incision de M. McBurney, de M. Kocher, de M. Springale.

Il y a pas mal d'incisions. L'incision de Fenechil. Il y en a certaines qui sont plus fréquentes que

d'autres.

Par exemple, l'incision de Fenechil, elle est très fréquente. C'est avec celle-là qu'on fait la césarienne. Donc, elle est extrêmement fréquente.

L'incision de McBurney aussi, elle est fréquente. C'est avec celle-là qu'on fait l'appendicectomie. On fait de plus en plus d'appendicectomies par celluloscopie.

L'incision sous-costale droite aussi, appelée également incision de Kocher, elle est aussi fréquente. Elle reste fréquente, même si là aussi, nous faisons quasiment toutes les visicules, toutes les colistectomies par voie celluloscopique. Mais il nous arrive de traiter des patients par les incisions sous-costales, notamment lorsqu'on traite des lithiases de la vésicule biliaire principale, par exemple, ou des kystes.

Vous n'êtes pas censé connaître toutes ces incisions. C'est juste un schéma pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une incision de laparotomie. Facteur de risque.

Avant de passer au facteur de risque, il y a des questions qui tombent. S'il vous plaît, une hernie, ça siège au niveau des ondes de faiblesse à distance de l'incision, ou ça survient juste au niveau de la cicatrice d'ouverture. Initialement, la réponse, elle dépend en fait de la compréhension de ce que c'est qu'une laparotomie.

Lorsqu'on fait une laparotomie, on prend le bistouri, notre lame, on ouvre la peau, puis on prend le bistouri électrique. On commence à ouvrir les différentes couches musculaires. On va traverser les couches musculaires.

Et puis après, à la fin de l'intervention, le chirurgien doit refermer ce qu'il a fait. Il doit refermer les laparotomies. En refermant la laparotomie, il prend un fil, il commence à coudre, à refermer les différents plans qu'il a ouverts.

Le premier plan musculaire, le deuxième plan musculaire, et puis la peau par la suite. Forcément, l'éventration, elle survient lorsque le sujet ou les points qu'on a mis sur le muscle lâchent. Les points qu'on a mis sur le muscle vont lâcher à cause de certains facteurs de risque qu'on pourra citer.

Vous avez un patient qui est obèse, vous avez un patient qui tousse, qui est un fumeur, un patient qui est asthmatique. Lorsqu'il va commencer à tousser, lorsqu'il va provoquer une hyperpression abdominale, lorsqu'on a également une infection, si vous avez une infection, une suppuration du cicatrice, vous avez un microbe qui va un petit peu manger les fils que vous avez mis chez votre patient. Et puis le nœud va s'ouvrir.

Lorsque le nœud va s'ouvrir, la plaie que vous avez refermée va se réouvrir. En se réouvrant, le péritoine va ressortir. Ça va créer ce qu'on appelle une éventration post-opératoire.

Est-ce qu'on peut avoir une hernie sous-ombilicale? Sous-ombilicale, c'est extrêmement rare. Parce qu'anatomiquement, il n'y a pas de ligne blanche. C'est pour ça que l'anatomie est importante.

Il n'y a pas de ligne blanche en sous-ombilicale. La ligne blanche siège au niveau sous-ombilical. Donc la hernie de la ligne blanche, par définition, n'est pas une hernie sous-ombilicale.

C'est une hernie qui siège au-dessus de l'ombilique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas de ligne blanche. Normalement, chez plus de 90% de la population, il n'y a pas de ligne blanche sous-ombilique.

Maintenant, il y a des raretés, bien sûr. L'anatomie que l'on vous enseigne ou que vous avez dans les livres, c'est une anatomie qui est la plus fréquente. Mais ce n'est pas l'anatomie de tous les êtres humains.

On a des raretés. On peut avoir quelques fois des hernies pures de la ligne blanche en sous-ombilicale. Mais elles sont extrêmement rares.

En 20 ans de chirurgie, je n'en avais quasiment jamais vu. La plupart des hernies que j'opère de la ligne blanche sont en sous-ombilique. Donc, si vous en avez une, c'est que c'est une rareté.

Tout simplement. Voilà. Donc, les facteurs de risque sont importants à connaître.

Si vous révisez un peu les QCM, il ressort assez souvent ces facteurs de risque parce qu'ils expliquent pas mal de choses en matière de la survenue des hernies. Une hernie peut survenir, peut survenir chez n'importe qui. D'accord.

Mais il y a une fréquence qui est plus importante que pour toute pathologie. Il y a certaines choses, certains facteurs de risque qui font qu'on fait plus de hernie par rapport à la population générale. Donc, notamment l'obésité.

Lorsqu'on est obèse, on fait plus d'hernie parce que les muscles sont faibles. Lorsqu'on est sédentaire, c'est la même chose. On a des muscles qui sont faibles.

La hernie peut survenir. Lorsqu'on fait un travail de charge, lorsqu'on porte des choses qui sont lourdes, forcément on va mettre en jeu plus souvent notre muscle. Ça peut se déchirer.

Ça peut créer une hernie. Et puis les facteurs qui font qu'on a une hyperpression abdominale. Notamment lorsqu'on tousse, essayez un petit peu de tousser et mettez votre main sur votre abdomen.

Lorsque vous toussiez, vous allez sentir que vos muscles abdominaux se contractent. Et donc, en se contractant, forcément, ça va faire augmenter la pression abdominale et ça peut favoriser la survenue d'une hernie. La constipation aussi.

Lorsqu'on est constipé, lorsque les selles sont dures, lorsqu'on pousse, ça peut provoquer une hyperpression abdominale. La dysurie, même mécanisme. Lorsqu'on pousse pour pouvoir faire sortir ses urines, ça augmente la pression abdominale et ça peut favoriser la survenue d'une hernie.

Diagnostic. Alors, diagnostic, il est clinique. Il est le plus souvent clinique.

Vous, en tant que médecin, praticien, lorsque vous serez des internes soit du CHU, soit des internes de garde en 6e année, soit des internes de 7e année en hôpital périphérique, vous serez forcément confronté à des hernies. Et le diagnostic d'une hernie, c'est un diagnostic qui est clinique, tout simplement. Il y a certains caractéristiques qui sont typiques.

Vous avez une petite boule qui va sortir à travers une zone de faiblesse. Les zones de faiblesse qui sont classiques, vous les connaissez maintenant. C'est la région épigastrique, c'est la région péri-ombilicale et c'est la région de l'aine.

Vous avez une petite boule qui va sortir. Lorsque la hernie n'est pas compliquée, elle a des caractéristiques qui sont typiques d'une hernie qui est simple. Ça, c'est une question qui sort souvent parce que vous devez connaître ça.

Pour moi, en tant qu'enseignant, si je vous fais passer ce message-là en tant que futur médecin généraliste, ou quelque soit votre spécialité, un médecin généraliste doit connaître ce qu'est une hernie simple, une hernie non compliquée. Une hernie qui n'est pas compliquée est une hernie qui ne donne pas mal, qui n'est pas douloureuse. Elle est non douloureuse, donc ça c'est très important.

Si vous avez une hernie qui commence à faire mal, pensez à la complication. Vous avez une hernie. Lorsque vous mettez votre main, vous déshabillez le patient, vous poussez la hernie dans la cavité abdominale, elle revient dans la cavité abdominale.

Elle est réductible dans la cavité abdominale. Lorsque vous posez votre main sur la hernie et que vous demandez au patient de tousser, vous allez sentir une petite vibration. Vous allez sentir que la hernie transmet la vibration dans votre tour.

Ça se voit, on entend que le collet est assez large. Ça se voit, on entend que la hernie n'est pas étranglée et n'est pas compliquée. C'est important.

On va revenir à ça. On l'a déjà vu. Pour les hernies de l'aine, toujours en diagnostic, on a en avant deux grands types d'hernie.

Les hernies inguinales et les hernies crurales ou hernies fémorales. C'est la même chose. Hernie fémorale ou hernie crurale, c'est la même chose.

L'hernie inguinale, c'est ça. L'image que vous allez avoir. Pour examiner un patient qui a une

hernie inguinale, j'ai oublié de vous dire ça.

C'est un réflexe qu'il faut avoir. C'est une petite astuce que je vous donne. Toujours examiner le patient dans des positions qui sont différentes.

On demande au patient tout d'abord d'être debout. Vous l'examinez en position debout. Pourquoi? Parce que parfois, vous avez des petites hernies qui ne sont pas visibles lorsque le patient est en position couchée.

Lorsqu'on est en position couchée, les viscères se réintègrent spontanément dans la cavité abdominale. Parfois, les hernies seront difficiles à mettre en évidence. Commencez par déshabiller le patient et par le mettre en position debout face à vous.

Parfois, juste en position debout, vous lui demandez de tousser, de faire un petit effort de contraction de la paroi abdominale. Vous allez voir que le patient a une petite boule qui va sortir. Maintenant, cette boule là, il faudra la caractériser.

C'est une hernie qui est très fréquente, qui est même la plus fréquente entre la hernie inguinale. Si on vous pose la question, quelle est la hernie la plus fréquente? C'est la hernie inguinale. Est-elle plus fréquente chez les hommes que chez les femmes? Là aussi, c'est une question qui sort.

Oui, elle est plus fréquente chez les hommes. C'est important. Par rapport à la hernie crurale qu'on va voir tout à l'heure.

La hernie crurale est la plus fréquente chez les femmes. Et le siège? Là aussi, c'est une question qui sort trop souvent. Au-dessus de la ligne de Malgène, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la ligne de Malgène? C'est une ligne que vous avez sûrement vu dans l'anatomie en première année.

Mais bon, c'est loin, ça remonte à deux ans quand même. C'est tout simplement une ligne qui va joindre l'épine iliaque à l'épine du pubis. Vous tracez une ligne virtuelle entre l'épine iliaque et l'épine du pubis.

Ce qui est en dessous, c'est inguinal. En haut de cette ligne-là, c'est une hernie inguinal. Ce qui est en dessous, ce qui est en bas, c'est fémoral ou crural.

Donc, en dessous, inguinal. En dessous, c'est fémoral. Je vous ai prévenu, c'est une question qui sort souvent.

Fémoral, c'est ce qu'on a dit. Fémoral, c'est l'inverse. Fémoral, c'est une hernie qui est plus fréquente chez les femmes.

Pourquoi est-ce qu'elle est plus fréquente chez les hommes? Elle est plus fréquente chez les hommes parce que les hommes ont un organe particulier qui passe à ce niveau-là. On a le

cordon spermatique. Les hernies inguinales sont le plus souvent des hernies qui vont suivre le trajet du cordon spermatique.

Le cordon spermatique va traverser cette région-là et le cordon spermatique, dans sa construction, dans sa structure anatomique, il est au-dessus de la ligne de Malgré. Chez les femmes, c'est plus bas parce qu'elles ont l'équivalent d'un cordon spermatique. Elles ont ce qu'on appelle le ligament rond de l'utérus.

Le ligament rond de l'utérus, c'est un tout petit cordon fibreux. Ce n'est pas comme le cordon spermatique qui est plus gros, qui est plus consistant. Souvent, la hernie va suivre ce cordon spermatique.

C'est ce qu'on appelle les hernies indirectes. Les hernies qui vont suivre le trajet du cordon spermatique. C'est pour cela que c'est plus fréquent chez les hommes.

Chez les hommes, c'est en-dessus à cause de ce cordon spermatique. Chez les femmes, c'est en-dessous. C'est plus bas que le cordon spermatique.

Il n'y a pas que la hernie comme petite boule qui peut apparaître dans la région de l'aîne. Faites attention. Souvent, le diagnostic est évident.

Mais chez certains patients, le diagnostic n'est pas évident. Par exemple, chez les patients qui sont obèses. Les patients qui sont obèses peuvent avoir un peu de graisse dans la région de l'aîne.

C'est ce qu'on appelle un lipome. On peut avoir également un quiste du cordon. On a parlé de ce fameux cordon spermatique qui traverse la région.

Ce cordon spermatique peut être le siège du quiste. On peut parfois prendre, par inadvertance, le quiste pour une hernie. Faites attention.

On peut avoir un ganglion. Une petite inflammation d'un ganglion à ce niveau-là. Ce qu'on appelle une adénite.

On peut avoir un hydrosel. Une dilatation de la vagina avec un liquide. Un épanchement dans la vagina du testicule.

On peut même avoir une ectopie testiculaire. Un testicule qui n'a pas migré complètement. Qui est resté en position inguinale.

Et qu'on peut prendre pour une hernie inguinale. Dans les cas qui sont ambiguës. Qui vous posent problème par rapport à ça.

On peut être amené à demander une échographie abdominale. Dans certains cas. Mais c'est extrêmement rare.

Souvent, vous avez une masse qui est réductible. Qui est impulsive. Qu'on arrive à retrouver dans la région inguinale.

Et qui fait qu'on est quasiment sûr du diagnostic de hernie inguinale. Maintenant, si on a un doute. Est-ce qu'ils sont douloureux? Qu'est-ce qui est douloureux? Est-ce qu'ils sont douloureux? On a dit qu'une hernie qui est simple n'est pas douloureuse.

Si vous avez une douleur. Ça sous-entend que soit que ce n'est pas une hernie. Soit que c'est une hernie qui est compliquée.

Ce qui est douloureux, l'adénite. Oui, l'adénite est douloureuse. Parce que c'est une inflammation.

L'adénite est douloureuse. Les autres peuvent ne pas être douloureux. S'ils ne sont pas compliqués.

Un lipon qui n'est pas compliqué, qui n'est pas infecté, n'est pas douloureux. Un kyste qui n'est pas compliqué, n'est pas douloureux. L'hydrocelle n'est pas douloureuse.

Et l'ectopie, quand elle n'est pas compliquée là aussi, n'est pas douloureuse. Ce sont surtout des petites boules, des petites masses qui peuvent poser problème. C'est pour ça que je les ai mises dans le diagnostic différentiel des hernies.

Ensuite, hernie ombilicale. Hernie ombilicale, c'est un patient historique. Les hernies ombilicales ne sont pas aussi moches que celle-là.

C'est une grosse hernie ombilicale. C'est une tuméfaction, normalement. L'ombilique normal, tout le monde le connaît parce que tout le monde l'a, tout simplement.

C'est une hernie. C'est une petite dépression au milieu abdominal qu'on a tous. Une petite cicatrice de ce fameux cordon ombilical qu'on avait.

Puis, on peut avoir une petite boule à ce niveau-là qui va se former. Elle est plus fréquente chez les femmes obèses et également en cas de cirrhose. Les femmes, parce que l'ombilique est plus large chez les femmes par rapport à l'homme anatomiquement.

Les obèses, là aussi, c'est une dilatation un petit peu de la région ombilicale. Les patients cirrhotiques ont souvent un épongeement. Ils ont souvent de l'acide.

L'acide fait qu'on a une distanciation abdominale qui va favoriser l'apparition des hernies ombilicales. Ici, c'est une hernie épigastrique. Là aussi, c'est un patient qui était obèse.

Je me souviens bien de ce patient-là. C'est une juminfraction de la ligne blanche en dessus de l'ombilique. C'est une hernie qui va se projeter sur la région épigastrique.

C'est une masse sur la région épigastrique. Et souvent, elle contient le ligament rond du foie. Parce que le ligament rond du foie, anatomiquement, il va traverser cette région-là.

Il va scinder un petit peu le foie en deux. Puis, il va se continuer en sous-cutanée, sous la paroi, pour aller rejoindre la région ombilicale. Et c'est souvent ce cordon, ce ligament rond qui va siéger dans la hernie de la ligne blanche.

Mais bon, ça, c'est un petit détail à connaître. Là, c'est une rareté. C'est une hernie de Spiegel.

C'est une patiente que j'avais opérée par stéioscopie. La hernie de Spiegel est rare. C'est une hernie qui va siéger sur le bord externe du muscle grand droit de l'abdomen.

Sur le bord externe du muscle grand droit de l'abdomen, il y a une petite zone de faiblesse qu'on appelle la ligne de Spiegel. Et sur cette zone de faiblesse qui est la zone de Spiegel, la ligne de Spiegel, on peut avoir des petites boules qui vont sortir qu'on appelle les hernies de Spiegel. Je vais avancer parce que quasiment, on est un petit peu loin du timing, mais on va y arriver.

Aller, éventration post-opératoire. Ce sont des éventrations des hernies qui sont acquises. La parotomie et la paroscopie.

Là, vous voyez sur l'image un patient qui a eu une belle incision médiane. Et sur l'incision médiane, là aussi, même chose. Vous avez une tumeur fraction qui va sortir à travers la cicatrice.

Donc, à chaque fois qu'on fait une cicatrice sur un patient, qu'on opère un patient, il y a toujours le risque qu'il y ait une éventration post-opératoire. Dans certaines publications qui sont récentes, vous pouvez avoir le terme de hernie incisionnelle. Hernie incisionnelle, c'est la même chose qu'une éventration post-opératoire.

Ça revient en même. Hernie incisionnelle ou éventration, c'est exactement la même chose. La paroscopie aussi, c'est possible.

Parce que même dans la paroscopie, on utilise ce qu'on appelle des trocars pour opérer les patients. Et ces petits trocars, en gourmand, étranglement, on va y arriver. Parce que lorsqu'on parlera des complications, on va y arriver.

En gourmand, étranglement, parce que là, on est toujours dans le diagnostic. On n'est pas encore dans les complications. Donc, la paroscopie peut être également le siège, les petits orifices, les petits trocars, peut-être le siège d'éventration post-opératoire.

Et la taille, elle est variable. Voilà. Donc, on arrive aux complications.

On va avancer. Voilà. Donc, trois complications, pas mal de complications.

Mais les trois les plus fréquentes que je vous ai mises, pour ne pas trop vous encombrer l'esprit,

que vous devriez plus ou moins connaître en tant que médecin généraliste ou en tant que futur praticien, c'est l'étranglement herniaire, c'est l'engouement et c'est le trouble trophique cutané en regard d'une grosse hernie. De quoi je parle? Voilà. Donc, l'étranglement, c'est ça.

Alors, l'étranglement, c'est une extrême urgence. Pourquoi? Parce que souvent, souvent dans les hernies, on a un condominium intestinal qui ressort malheureusement. Donc, si vous voyez un petit peu la coupe qu'on a, l'image que vous avez, vous avez un orifice.

Et à travers l'orifice, vous avez l'intestin qui sort. Et cet intestin qui sort va être strangulé, va être étranglé. Donc, étranglé, c'est quand vous prenez une cravate, que vous mettiez autour du cou et que vous seriez la cravate.

Quand vous serrez la cravate, vous avez la même chose par rapport à la hernie, d'accord? Si vous serrez la cravate, vous ne pourrez plus respirer. Et donc, la pauvre once, c'est la même chose qui va lui arriver. Vous avez une once intestinale qui ressort à travers un trou.

Et après un certain moment, ça commence à serrer sur la base du trou. Donc, en serrant, il y aura plus de sang qui va arriver au niveau de l'once intestinale. Elle va commencer à souffrir.

Et si l'étranglement se prolonge, elle va se nécroser. Et en se nécrosant, le risque peut même se perforer, peut se rompre. Donc, si elle se rompt, forcément, oui, ça peut se compliquer.

Ça peut même entraîner des péritonites et engager le pronostic vital du patient. Petite parenthèse, est-ce que le risque d'événtration est réduit avec la stéréoscopie? Oui, avec la stéréoscopie, il est réduit. Pourquoi? Parce que les incisions sont beaucoup plus petites.

Plus l'incision est grande, plus le risque d'événtration est grand. Plus l'incision est petite, plus le risque est moindre. Et donc, forcément, dans la stéréoscopie, on a de petits trous qui font un centimètre entre 5 mm et 10 mm par rapport à une incision qui fait 4, 5, voire 10 centimètres.

Le risque par rapport à une stéréoscopie. Oui, parce qu'on fait une stéréoscopie, on a beaucoup moins de risque de faire une événtration par rapport à une chirurgie classique. Voilà pourquoi, en cas de perforation, on fait une stomie au lieu de suturer.

On va arriver, on va arriver au traitement. On n'est pas encore au traitement. Là, on est en train de parler des complications.

Voilà. Donc, pour rester dans l'étranglement herniaire. Donc, les trois signes que vous devez connaître, ça, je vous le dis.

Il y a des choses que vous devez connaître, sur lesquelles j'insiste, parce qu'elles peuvent être posées le jour de l'examen. C'est bien de poser des questions pour que ça permet d'ouvrir un petit peu le champ de la discussion. Mais moi, en tant qu'enseignant, je m'adresse à des étudiants en troisième année.

Donc, je forme des médecins généralistes. Et donc, forcément, j'ai des objectifs que vous devez valider. D'accord.

Ça, c'est clair. Donc, des choses que vous devez absolument connaître. D'accord.

Il y a des choses qui sont plus techniques, sur lesquelles vous ne serez pas évolués. Par rapport à ma vision des choses, vous ne serez pas évolués par rapport à des choses qui sont plutôt techniques. Vous n'êtes pas résident en chirurgie viscérale.

Vous ne serez pas des chirurgiens. Enfin, pour l'instant, vous êtes formé pour être des médecins généralistes. Mais donc, vous êtes censé connaître des choses de votre niveau qui peuvent vous servir dans votre pratique commune en tant que médecin généraliste.

D'accord. Alors maintenant, une hernie étranglée. Les trois signes que vous devez connaître et qui ressortent souvent dans les QCM.

Une hernie étranglée est une hernie qui est douloureuse. C'est une hernie qui fait mal aux patients. C'est une hernie qui n'est pas réductible, qu'on n'arrive pas à réduire.

Et c'est une hernie qui n'est pas impulsive à la toux. Retenez ces trois signes. Ils sont très importants.

Douloureuse, non réductible et non impulsive à la toux. C'est très important. Donc, ces trois choses-là, elles ressortent souvent dans les questions d'examen.

Il ne faut pas se tromper. Si je vous dis que vous avez une hernie qui est douloureuse, non réductible et non impulsive à la toux, c'est une hernie qui est étranglée. Ce n'est pas une hernie qui est simple.

Point à la ligne. D'accord. Maintenant, je vais arriver à la réponse.

Il y a une consœur, une de vos amies qui m'a dit qu'est-ce que la différence entre étranglement et engouement. Dans l'étranglement, c'est un phénomène qui est brutal, qui se revient de façon brutale. Vous avez un sac herniaire.

Vous avez de l'intestin qui sort tout d'un coup. Et puis, tout d'un coup, on a commencé à serrer. Ça ne revient plus dans l'abdomen.

D'accord. Donc, on n'en parle plus. C'est une extrême urgence.

C'est ça, l'étranglement herniaire. L'engouement, non. L'engouement, c'est un phénomène.

L'engouement est un phénomène qui est plus insidieux, qui est plus progressif. Il est dû à quoi, en fait? Il n'est pas dû à un étranglement. Ce n'est pas la base du sac qui s'étrangle autour d'une enceinte intestinale.

C'est plutôt la chronicité. Vous avez une hernie qui dure depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans chez un patient. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, des adhérences vont se créer entre le sac herniaire et le contenu qu'il contient à l'intérieur.

Et donc, ces adhérences-là vont faire qu'on va avoir des petits épisodes à répétition, des petits épisodes douloureux. On va avoir de la douleur. Mais la principale différence, c'est que la hernie ou le sac herniaire est impulsif à l'intérieur.

D'accord? Donc, c'est une hernie qui est parfois douloureuse avec des épisodes douloureux à répétition qui sont régressifs. Pas comme dans l'étranglement où la douleur est continue. Ce sont des hernies qui ne sont pas réductibles comme la hernie qui est étranglée, mais qui ne sont pas réductibles.

Pourquoi? Parce qu'on a des adhérences. Mais la seule différence, c'est que la hernie est impulsive à l'intérieur. Lorsque vous posez votre main, les impulsions sont transmises.

Pourquoi? Parce que la base du sac n'est pas étranglée, n'est pas fermée. Donc, il y a toujours du sang. Il y a toujours un apport sanguin qui arrive dans l'enceinte intestinale.

Et donc, forcément, la hernie est impulsive à l'intérieur. Donc, elle est douloureuse. Une hernie engouée est douloureuse.

Oui. Elle n'est pas réductible. Oui.

Elle est impulsive. Oui. Donc, c'est très important.

D'accord? C'est ça la différence. Un de vos amis m'a dit, est-ce que toute hernie va donner un syndrome occlusif? Non. Même la hernie simple? Non.

Alors, une hernie simple, déjà, elle ne donne aucune complication. C'est une petite boule qui sort, qui dérange le patient sur le plan esthétique, qui n'a aucune répercussion. D'accord? Lorsqu'elle se complique, elle peut avoir certains signes cliniques.

Mais, le plus souvent, le seul signe qu'on a, c'est une petite boule qui va ressortir. Donc, ça, c'est un. Maintenant, est-ce que toute hernie va donner un syndrome occlusif? Non.

Parce qu'on peut avoir des hernies qui contiennent juste de l'épiplan, qui contiennent juste de la graisse abdominale. Donc, si la hernie contient juste de l'épiplan, il n'y a aucune raison pour que le patient fasse une occlusion intestinale. L'occlusion intestinale, c'est lorsqu'on a un obstacle sur le transit, sur le trajet intestinal normal.

Pardon. L'obstacle survient lorsque vous avez une once intestinale qui est piégée dans une hernie. Tout simplement.

Donc, lorsque vous avez une hernie qui est simple, il n'y a pas d'occlusion. Lorsque vous avez une hernie étranglée à contenu intestinal, oui, ça peut donner un syndrome occlusif. J'espère que ça a été clair.

D'accord. Question perforation. Est-ce que le gourmand est aussi une urgence chirurgicale? Non, ce n'est pas une urgence chirurgicale.

C'est une complication qui est insidieuse, qui est chronique. Mais parfois, la distinction entre les deux n'est pas évidente. Parfois, on peut même ramener à faire des scanners pour faire la distinction entre les deux, pour voir si l'once intestinale est viable.

Parfois, le doute persiste chez certains patients. Mais ce n'est pas une extrême urgence aussi urgente que l'étranglement hernial. C'est une complication, mais ce n'est pas une extrême urgence chirurgicale.

C'est important. Voilà. Donc, on va passer au traitement.

Pour conclure, parce qu'on a vraiment tardé sur la pathologie pariétale. Comme j'ai dit, si je vous pose la question dans l'examen traitement d'une hernie, il est médical, vous ne cochez pas. Ça, c'est clair.

D'accord. Troubles cutanés. Je vous laisse.

Je laisse. Je laisse mes amis dermatologues vous en parler. On peut avoir des troubles trophiques cutanés qui peuvent aller jusqu'à la nécrose cutanée.

Donc, vous avez tous les troubles possibles qui vont de la souffrance intestinale, de la souffrance cutanée. Pardon. Jusqu'à la nécrose cutanée.

Quasiment. D'accord. Due à la compression.

Parce que vous avez de gros sacs. Les gros sacs vont comprimer la peau. Ce n'est pas un cours de dermatologie que vous faites.

C'est un cours de chirurgie. Et donc, forcément, je n'insiste pas dessus. Troubles cutanés.

Retenez qu'ils sont possibles. Mais que vous ne serez pas évolués là-dessus. Excusez-moi.

J'ai perdu un petit peu ma voix. Alors. Moi, je vous passe des messages qui sont les plus importants.

L'un des messages les plus importants dans une hernie, par rapport à ce que je vous enseigne. Le traitement d'une hernie est toujours chirurgical. Oui.

Vous cochez. D'accord. Je ne vais pas traiter une hernie en mettant un petit bondage.

Je ne vais pas traiter une hernie en donnant un laxatif. Je ne vais pas traiter une hernie en donnant un judicatif. Non.

Je traite une hernie en adressant le patient chez le chirurgien. Pour qu'il puisse résoudre le problème. Parce que la hernie, c'est quoi? C'est un trou.

Tout simplement. Pour le dire banalement. C'est un trou dans la paroi abdominale.

Si vous avez un trou dans la paroi abdominale. Le seul traitement possible, c'est de fermer le trou. Tout simplement.

Et ça, seul le chirurgien peut le faire. Seul la chirurgie peut résoudre ce problème-là. Alors maintenant, comment refermer ce trou? Cet orifice? Il y a deux façons.

Soit qu'on va céder des apports névraux. Ce qu'on a déjà sur place. Des muscles qu'on a sur place.

Soit qu'on va mettre en place une prothèse. Donc un matériel prothétique qui va refermer. Qui va aider à refermer l'orifice.

Voilà. Donc par rapport au traitement apport névrotique. Comme j'ai dit.

Il y a plusieurs techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que ce n'est pas le but du cours.

Je ne vais pas vous poser des questions par rapport aux détails techniques. Ce n'est pas le but du cours. Retenez juste qu'on peut traiter une hernie.

Par suture apport névrotique. D'accord? On peut mettre un fil. Un fil de soie.

Un fil qui n'est pas résorbable. On peut rapprocher les muscles. Et refermer le trou qu'on a fait.

Tout simplement. Le seul problème avec ces procédures-là. C'est que les récidives sont très fréquentes.

Pourquoi? Parce que. Supposer que vous avez un patient qui est obèse. Supposer que vous avez un patient qui n'a pas une musculation qui est très développée.

Vous ouvrez. Vous trouvez la hernie. Vous mettez votre fil.

Vous êtes content. Ou pas. Vous êtes bien.

Le patient. Il a un muscle qui est très très faible. Dès qu'il va tousser.

Dès qu'il va bouger. Dès qu'il va porter quelque chose de lourd. Le fil peut sauter.

Et si le fil saute. Il va encore faire une récurrence. Il va faire une éviscération.

Il va faire une hernie incisionnelle. Et donc, les récurrences peuvent valoir jusqu'à 40% des patients qu'on obtient. D'accord? Et donc, forcément, les indications du traitement apport névrotique.

Elles se réduisent de plus en plus. Maintenant, actuellement, on les limite quasiment aux toutes petites hernies. Ou aux urgences.

Aux grandes urgences, en fait. Lorsque vous avez une péritonite. Lorsque vous avez du pus.

Lorsque vous avez des matières fécales dans l'abdomen. Je ne peux pas mettre une prothèse parce qu'elle va s'infecter. Donc, je suis obligé de mettre un fil pour suturer.

D'accord? Donc, traitement apport névrotique. Oui, on peut le réaliser. Mais il donne beaucoup plus de récurrence.

Et il a des indications de plus en plus limitées. En 2021. À l'instant où je vous parle.

Voilà. Traitement apport névrotique. Ça, c'est par exemple.

Lorsque vous avez une hernie inguinale. Donc, voilà. Donc, on enlève le sac.

On met un fil. On referme. On rapproche les muscles par un fil.

Tout simplement. Traitement prothétique, c'est quoi? Il y a plusieurs termes. Il y a plusieurs.

Le blaca. La plaque. La prothèse.

Le filet. Chuka. Donc, tout ça.

C'est ce qu'on appelle une prothèse. Donc, la prothèse, c'est un matériel exogène. Ce n'est pas un matériel du corps humain.

C'est une prothèse qui se vend. Il y a plusieurs types de prothèses. Il y a plusieurs matériaux qu'on peut utiliser.

Le plus utilisé actuellement, ce sont les plaques de polypropylène. On peut avoir des plaques qui sont résorbables. Des plaques qui vont régresser spontanément.

On peut avoir des plaques qu'on appelle bifers avec du collagène. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous n'êtes pas censé connaître toutes ces choses-là.

Vous êtes en troisième année. Quand vous serez au service, on peut parler de tout ça au large. Mais maintenant, par rapport aux choses que vous devez connaître, par rapport aux choses que vous devez saisir en tant qu'étudiant en troisième année, retenez qu'en 2021, le traitement prothétique est le traitement idéal pour traiter une hernie.

Pourquoi? Parce que la prothèse en elle-même, ce n'est pas elle qui va guérir la hernie. Lorsqu'on pose une prothèse dans un corps humain, il y a certains phénomènes qui vont se créer. La prothèse est un corps étranger.

Donc, elle sera attaquée dans un premier temps par les phénomènes inflammatoires du corps humain. Elle sera attaquée par les globules blancs quasiment. Il n'y aura pas d'infection.

Il n'y aura pas de pume. Il y aura de l'inflammation. Et puis, il y aura une guérison, un mode de guérison.

Comme vous le savez, le mode de guérison le plus souvent dans le corps humain, c'est la construction d'une fibrose. Cette couche de fibrose, elle va se déposer sur la prothèse. En se déposant sur la prothèse, elle va créer un barrage qui va empêcher la sortie des hernies.

Donc, la prothèse en elle-même, ce n'est pas elle qui traite la hernie. C'est la fibrose que votre corps développe au contact de la prothèse qui fait qu'on va traiter une hernie. Cette notion-là, elle est importante.

On peut la poser soit par la parotomie, soit par la paroscopie. Ça aussi, c'est important à connaître. Et ce qui est le plus important, c'est que les récidives sont extrêmement faibles.

Si vous comparez 5% par rapport à 40% de tout à l'heure, il n'y a pas de discussion. C'est pour ça qu'actuellement, nous utilisons de plus en plus le traitement prothétique pour traiter les patients qui ont des hernies. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup moins de récidives par rapport au traitement à point névrotique.

Les complications, oui, elles sont possibles. Le principal risque lorsqu'on pose une prothèse, c'est d'avoir un corps étranger qu'on met dans le corps humain. Et tout corps étranger peut s'infecter.

C'est une des complications qui sont possibles. En avance, ce sont des images chez certains patients qu'on a opérés, soit par stéioscopie, soit par chirurgie ouverte. Par exemple, si vous voyez l'image qui est en haut à droite, vous avez une prothèse, une plaque qu'on a mise par voie stéioscopique et qu'on a fixée.

C'est un patient qui avait une éventration post-opératoire. Si vous voyez l'image qui est juste en dessous, vous voyez qu'on a fait une laparotomie. On a ouvert l'abdomen, on a mis la plaque et puis sur la plaque, on va refermer.

On va refermer le muscle et la peau sur la plaque. Sur la dernière image, en bas et à gauche, c'est une hernie inguinale qu'on avait opérée par stéioscopie. On a mis la plaque et on va refermer le péridoire sur la plaque.

Ce sont des petites choses qui sont bien à connaître par rapport à votre niveau. Conclusion pathologique très fréquente que vous devez connaître en tant que médecin généraliste.

Diagnostic souvent clinique, complications parfois graves.

Notamment lorsque vous avez un étranglement herniaire. Cela peut aller à la perforation, au péritonite, au syndrome occlusif. C'est grave en termes de complications.

Traitement chirurgical, je vous l'ai dit. Vous êtes censé le connaître. Un traitement d'une hernie est un traitement qui est chirurgical, le plus souvent en 2021 par des prothèses.

Idéalement par la paroscopie. On a fini avec le cours de la pathologie herniaire. Je me suis trop étalé dessus.

Malheureusement, je ne sais pas. J'espère que j'aurai une autre séance interactive avec vous. Parce que je ne pense pas que je vais arriver à faire les quatre cours en même temps.

En s'étalant de façon aussi succincte sur les différents cours. Je vais enchaîner avec les pancréatites. Je vais essayer de passer aux pancréatites.

Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport aux hernies. J'espère que c'est assez clair. La pathologie herniaire.

Une question par rapport à la perforation. Je reviens pour la voir. Alors, c'est pourquoi en cas de perforation, on fait une stomie au lieu de suturer.

On fait une stomie. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas dans mon cours.

Je suppose. Je pense que c'est le professeur de l'osier ou le professeur. Je ne me souviens plus.

Alors, on fait. Lorsque vous avez une perforation intestinale. Qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsque vous avez.

Là, je sors du cours. Je sors du cours des hernies. Je vous le dis bien.

Parce que ce n'est pas. Ça ne rentre pas dans le cours. Mais c'est juste à titre informatif.

Je suis chirurgien. Je peux vous aider par rapport à d'autres causes. Il n'y a pas de souci.

Lorsqu'on a une perforation intestinale, le contenu intestinal va se déverser dans la grande cavité abdominale. Donc, le patient sera en péritonite. Une péritonite, ce qu'on appelle une péritonite stercorale.

Vous avez des matières focales dans la cavité abdominale. Si on s'amuse à faire des points de suture, les sutures, on les fait avec du fil. Plus ou moins, c'est un fil qui est résorbable.

Résorbable, c'est un fil qui va fondre spontanément. Donc, on est à l'enlever, qui va disparaître spontanément. Le risque, lorsque vous faites des sutures sur un milieu qui est sceptique, c'est que vos sutures ont beaucoup de chance ou de malchance de lâcher.

Donc, le risque est énorme d'aller faire des sutures dans un milieu qui est sceptique. D'accord? Et donc, l'idéal, c'est de faire ressortir la perforation vers l'extérieur. Pourquoi? Pour donner le temps au corps humain pour cicatriser.

Donc, vous lavez, vous suturez, vous prenez la perforation, vous la ressortez à l'extérieur, vous faites ce qu'on appelle une stomie, soit une colostomie ou une ileostomie. D'accord? Vers l'extérieur. Vous lavez la cavité abdominale et vous laissez reposer le corps humain.

Vous laissez cicatriser et après un ou deux mois, vous réintégrez. Une fois que l'abdomen est propre, il est plus sceptique, il est bien. Vous réintégrez l'intestin à l'intérieur.

Voilà. C'est pour ça qu'on fait des colostomies ou des ileostomies sur la perforation intestinale. Mais ça ne fait pas partie, je suppose, de l'un de mes cours, je pense.

Voilà. Je vais essayer de passer au cours suivant. Attendez, les pancréatites.

J'espère que je vais y arriver. Voilà. Est-ce que vous avez les pancréatites? Non, il n'y a pas de souci.

Vous pouvez poser des questions, si c'est un sujet, il n'y a pas de souci. On est là pour vous aider. Alors, est-ce que vous avez le cours des pancréatites? Je voudrais avoir un retour, le cours des pancréatites.

Vous l'avez sur le diaporama? Pancréatite aiguë. Vous l'avez. OK.

Bien. Donc, on va y aller. Donc, comme j'ai dit, on est pris par le temps, malheureusement.

Donc, on est déjà, voilà, donc on est 16h, quasiment 16h50. La séance se termine à 17h30. J'espère que, bon, je vais voir.

Je pense qu'on va faire juste deux cours aujourd'hui. On va faire les pancréatites et la pathologie herniaire. Pourquoi? Pour avoir le temps de bien saisir les choses.

Déjà, ça c'est un. Et puis, je vais essayer de programmer une deuxième séance interactive pour les tumeurs hépatiques et les tumeurs biliaires. Parce que ce sont là aussi deux cours qui sont très, très lents.

Je pense que ce serait mieux pour tout le monde. C'est beaucoup mieux que d'aller trop vite, de bâcler les cours comme ça, sans s'insister sur les notions fondamentales. Bien.

Donc, directement, on va aller vers les pancréatites aiguës. Troisième année, études médicales. Alors, introduction.

Comme son nom l'indique, une pancréatite aiguë est une inflammation. Parce que c'est une

inflammation aiguë du pancréas. Urgence médico-chirurgicale.

Pourquoi médico? Parce qu'on n'opère pas les pancréatites le plus souvent en urgence. Donc, souvent, ce sont les services de médecine qui se chargent de la pancréatite aiguë. Et chirurgical, parce que le chirurgien peut intervenir en urgence comme il peut intervenir en différé.

Parce que la pancréatite, elle a été refroidie. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Je vous l'ai déjà dit dans le support audio que je vous ai donné.

Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait à hospitaliser une pancréatite dans notre service. Ce qui est malheureux dans notre contexte, malheureusement. Et cela est dû au fait que les étiologies sont le plus souvent dominées par les étiologies biliaires dans notre contexte.

Le plus souvent, les pancréatites chez nous sont dues à la présence de lithiases biliaires qui font qu'on a des pancréatites qui sont très fréquentes. Diagnostic, il est évoqué cliniquement. Donc, il est évoqué cliniquement par des signes cliniques qui sont typiques, qu'on verra en détail ensemble.

Et biologique. Biologique, il n'y a pas 36 000 choses à demander. Je vais insister dessus lorsque je reviendrai au diagnostic.

Donc, il y a un examen biologique à demander que vous devez connaître. Je vous pose une question dessus parce que je sais que vous répondrez tous à 100% à cette question-là. Mais si vous répondez tous à cette question-là, je serai content.

Parce que forcément, c'est un objectif que vous devez connaître en étant étudiant en troisième année. Pourquoi urgence médico-chirurgicale ? C'est ce que je viens de dire. Donc, médico, ça veut intervenir les spécialités médicales.

Et chirurgical, ça veut intervenir le chirurgien. Les spécialités médicales, ce sont les gastro-entérologues et les ré-alimentateurs. Pourquoi vous avez une pancréatite ? Le plus souvent, la pancréatite, on ne va pas l'opérer en extrême urgence.

On va y revenir lorsqu'on parlera du traitement. Mais lorsque le patient vient, il a besoin de deux choses. Il a besoin d'avoir un antalgique, sa douleur cesse.

Il a besoin d'un repos digestif. Et ces deux choses-là, le chirurgien ne les fait pas. C'est dans un service de médecine qu'on les fait.

Et secondairement, lorsque la pancréatite est refroidie, le chirurgien intervient pour traiter le patient. C'est pour ça qu'il est médico, parce que les spécialités médicales interviennent. Et chirurgical, le chirurgien intervient secondairement.

Autre question. Est-ce que la pancréatite lithiasique peut survenir sur un patient qui est

cholecystectomisé ? Oui, tout à fait. Parce qu'un patient cholecystectomisé, c'est un patient qui a enlevé sa vésicule biliaire.

Mais il peut avoir déjà un calcul qui a migré dans la vomière principale et qui est passé inaperçu. Et secondairement, après quelques années, le calcul va grossir. Et en grossissant, il va se bloquer.

Ça, on va l'expliquer. On va l'expliquer par la semaine. Mais oui, retenez que oui, un patient qui a été cholecystectomisé, au contraire, c'est un patient à risque pour faire une pancréatite aiguë.

Parce qu'il peut faire ce qu'on appelle une lithiase résiduelle de la vomière principale. Notion très importante, c'est qu'il y a deux grands types de pancréatite aiguë. Je l'introduis déjà maintenant initialement dans le cours.

Et c'est une notion qui va revenir. Dans ce cours-là, ce cours-là, il est bien codifié. Il y a des notions de base que vous devez connaître.

Je vais insister dessus. Vous avez la pathologie, la fréquence de la pathologie. Vous avez la cause biliaire.

Vous avez les génomes cycliniques confirmés par la lipasémie. Je vous le dis déjà. Et vous avez deux grandes familles.

La bénigne, pas de problème, qui n'est pas méchante. Et la grave, la méchante, qui peut engager le principe vital du patient. Je vous le dis d'emblée.

Donc, ce sont des notions capitales essentielles. Si vous retenez ça, vous avez quasiment saisi 90% du cours. Rien que sur ces notions-là que je vous ai dites à l'introduction.

Maintenant, on va développer ces notions-là. Un cours, ça sert à ça, en fait. Développer les notions qui sont un peu succinctes.

C'est un plan classique. Je ne vais pas insister dessus. Rappel, vous êtes de grands médecins maintenant.

En troisième année, vous connaissez tous ce que c'est que le pancréas ou pancréas. Les Belges disent pancréas. Les Français disent pancréas.

Les deux sont justes. Pancréas ou pancréas, c'est juste dans les deux sens. C'est une glande.

Que dire sur le pancréas? Une glande mixte. Une glande profonde. Le siège est important.

Le siège anatomique est important. La projection anatomique est importante. Le pancréas se projette sur la région épigastrique.

Ça, c'est une notion 1 qui est importante. Ça se vous entend qu'un patient qui a une pancréasite aura mal dans la région épigastrique. Ça, c'est 1. Deuxième notion importante.

Le pancréas est un organe rétro-peritoneal. Rétro-peritoneal est un organe qui est extrêmement profond. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs en anatomie.

Mais le pancréas... Derrière le pancréas, il n'y a plus rien. Derrière le pancréas, il n'y a plus que la horte. Et derrière la horte, il n'y a que le fascis.

C'est un organe qui est très profond. À partir de cette notion-là de profondeur du pancréas, vous comprenez que la douleur va se projeter en arrière. J'introduis déjà les notions de diagnostic et de sémiologie.

Mais une douleur pancréatique est une douleur postérieure. Pourquoi? Parce que le pancréas est un organe qui est postérieur. C'est un organe qui est quasiment plaqué sur la horte et plaqué sur le fascis.

Forcément, c'est pour ça que le patient aura une douleur qui est transfixante. Une douleur qui est postérieure. La physiologie, vous le savez déjà.

Ça, c'est plus récent. Vous l'avez vu en 2e année, je suppose. C'est encore plus frais dans vos têtes.

Sinon, c'est grave. Si vous avez oublié ça aussi, ce n'est pas évident. C'est une denterie endocrine qui régule la glycémie par l'intermédiaire de l'équilibre entre l'insuline et le glucagon.

C'est une glande qui est exocrine. Elle va sécréter un sucre pancréatique qui va digérer les lipides, glucéder les protéines. Malheureusement, c'est ce fameux sucre pancréatique qui va brûler le pancréas lorsqu'on a des pancréatites.

Au lieu d'être évacué, il va refluer vers le pancréas et il va provoquer une brûlure du pancréas qui va faire que le patient va avoir une inflammation et une pancréatite. Ça, on le verra en physiopathologie. Epidémiologie, pathologie très fréquente.

Donc, comme je vous ai dit, on va voir dans une semaine, 3, 4, 5 pancréatites qui sont hospitalisés dans le service. Ce n'est pas une bonne chose, au fait. Le fait qu'on ait beaucoup de pancréatites par rapport à l'Occident, par rapport à l'Europe, aux États-Unis, au Japon et aux pays occidentaux, ce n'est pas une bonne chose.

Pourquoi? Parce que ça sous-entend qu'on ne traite pas bien nos litiases biliaires. Si on diagnostiquait toutes les litiases biliaires et si on opérerait quasiment tous les patients qui avaient des litiases biliaires, nous n'aurions pas de pancréatites, tout simplement. C'est malheureusement chez les patients qui sont sous-diagnostiqués, les patients qui sont sous-traités, qui vont malheureusement développer des pancréatites aiguës.

La pancréatite aiguë, dans ce cas-là, sera un mode de révélation de la pathologie. Il y a beaucoup de pancréatites d'origine biliaire. Ce n'est pas une bonne chose, au fait.

Le terrain, c'est une femme. Parce que, comme vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vu dans le cours avec le professeur Blérier, dans le cours des lithiases biliaires, la pathologie lithiasique biliaire, souvent le profil type, c'est une femme adulte, jeune, qui a un calcul, qui a des coliques hépatiques, qui va faire une pathologie lithiasique biliaire. Et si elle ne traite pas cette pathologie lithiasique biliaire, la pathologie lithiasique biliaire va se compliquer de pancréatite, tout simplement.

Donc, c'est ça le profil. Les étiologies, là aussi, pour moi, vous devez connaître cette notion-là. Il n'y a pas de discussion.

Si je vous dis quelle est l'étiologie la plus fréquente de la pancréatite aiguë dans notre contexte, au Maroc, ici chez nous, c'est la lithiase biliaire. Ne cochez pas l'alcoolisme. L'alcoolisme, c'est en France, c'est aux États-Unis, c'est en Belgique, c'est ailleurs.

Mais au Maroc, l'étiologie la plus fréquente de la pancréatite aiguë, c'est la lithiase biliaire. Si vous ne la cochez pas, c'est à vous de voir. À côté, il y a des maladies qui sont plus rares.

Parce que les patients avec une pancréatite aiguë développent un diabète. Si c'est une complication aiguë, non. Mais une pancréatite chronique, oui.

S'ils font des pancréatites à répétition, ils peuvent développer un diabète. Ou s'ils ont une nécrose qui est très étendue. D'accord? Ça, c'est dans les complications.

On ne va pas s'étaler trop dessus. Si vous avez un patient qui a une nécrose étendue, parce qu'on le verra dans l'anapathie, parce que vous aurez des patients, parce qu'il y a deux types de pancréatites aiguës, on y reviendra par la suite. Pour répondre à ta question, oui.

Un patient qui a une pancréatite aiguë très évoluée avec une nécrose étendue du pancréas peut développer un diabète secondairement. Voilà. Ferme la parenthèse en continu.

Donc, j'ai dit qu'il y a d'autres étiologies. C'est juste pour les citer. Vous pouvez les avoir.

Donc, l'EPEUS, percalcémie, iatrogène, médicaments, hyperlipidémie. Donc, ce sont des étiologies qui sont possibles. Est-ce qu'on peut évoquer pancréatite aiguë devant des types d'iatrogènes après une colostomie? Oui, oui.

Oui, c'est une... Oui, on peut évoquer cette diagnostic, cette pancréatite aiguë, même si on a enlevé la vésicule, oui. Au contraire, si on a enlevé la vésicule, ça sous-entend que le patient a un terrain de lithiase. Donc, il peut avoir un calcul qui a déjà migré dans la... Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, oui.

Un patient qui est colostectomisé, c'est un facteur de risque pour faire une pancréatite aiguë. Retenez ça, parce que c'est la deuxième question qui va dans le même sens. Oui, c'est possible.

Voilà. Dans notre contexte, plus souvent, une femme entre 30 et 50 ans qui a des coliques hépatiques, et je le dis d'ailleurs, qui a eu une surgibilia dans les antécédents. Donc là, c'est clair et net.

Donc, une patiente qui a une surgibilia dans les antécédents, qui a enlevé sa vésiculaire ou qui ne l'a pas encore enlevé, mais qui a des symptômes qui évoquent une lithiase biliaire, pensez à la pancréatite. Et puis, gastrologie, pensez à la pancréatite, vous cochez la pancréatite. Physiopathologie, voilà.

Donc, on a ce qu'on appelle un mécanisme initiateur, un mécanisme qui va provoquer tout ce qui va venir. C'est toute la cascade qui va venir par la suite. Que ce soit une lithiase, l'alcoolisme ou le médicament.

Prenons le cas le plus simple de la lithiase, vous avez un calcul lithiasique qui va migrer de la vésiculaire vers le canal Colédoc, qui va descendre à travers le canal Colédoc jusqu'à l'ampoule de Vater. L'ampoule de Vater, il va bloquer, comme vous le savez, je suppose que vous le savez déjà. L'ampoule de Vater, il y a l'abouchement du canal Colédoc et du canal de Virsong.

Donc, le calcul va se bloquer à ce niveau-là. En se bloquant à ce niveau-là, il va empêcher les sécrétions pancréatiques de se déverser à travers le canal de Virsong. Donc, les sécrétions, au lieu d'aller vers le duodenum, à travers l'ampoule de Vater, elles vont refluer vers le pancréas.

En refluant vers le pancréas, elles vont activer les enzymes dans le canal de Virsong. Et donc, en activant ces enzymes-là, qui devraient normalement être activées dans le duodenum, elles seront activées dans le pancréas. Elles vont brûler le pancréas.

Donc, elles vont provoquer ce qu'on appelle l'autodigestion du pancréas. Et ça va créer la pancréasite. Donc, vous aurez une inflammation aiguë du pancréas.

Alors, les lésions inflammatoires, initialement, elles peuvent être localisées au pancréas, lorsque vous avez une pancréasite qui n'est pas méchante, qui est bénigne, mais elles peuvent être généralisées. Lorsque la pancréasite est très intense, on peut avoir des lésions qui sont en état de surclasie. Donc, retenez ça.

Vous avez un mécanisme initiateur. Vous avez des enzymes qui sont activées dans le pancréas, qui vont brûler le pancréas, qui vont digérer le pancréas, qui vont provoquer une inflammation du pancréas. Conséquences directes, lésions localisées au pancréas, inflammation du pancréas.

Quand ça dépasse le pancréas, il y a des phénomènes qui sont généralisés, des phénomènes inflammatoires généralisés. En APAT, retenez cette diapositive, elle est importante. Deux types

de pancréasites aigus.

Deux grands types, deux grandes familles. Le pancréasite très gentil. Donc, pancréasite très gentil, pas de problème, c'est ce qu'on appelle la pancréasite dématéose.

Le pancréasite s'est inflammé, il a augmenté de taille, il a eu de l'œdème. C'est ce pancréasite aigu, bénigne. Pas de souci, pas de problème.

D'accord ? Quels médicaments peuvent donner la pancréasite aiguë ? Ce sont surtout des anticancéreux. Donc, les anticancéreux qui donnent des pancréasites aiguës, je ne vous poserai pas de questions par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas censé connaître ça.

Pour moi, si vous savez que la lithiase biliaire est la cause la plus fréquente de la pancréasite aiguë au Maroc, ça me suffit. D'accord ? Ne cherchez pas le problème et ne causez pas de problème par rapport à vos amis parce que si je vous donne des informations dans le cours, je suis censé pouvoir vous donner des questions dessus. Donc, ne demandez pas des questions qui peuvent par la suite vous poser certains problèmes, certains soucis.

D'accord ? Je vous donne l'essentiel dans le cours. Vous n'êtes pas des médecins spécialistes, vous êtes des médecins généralistes. Donc, retenez ce qu'il y a dans le cours.

Voilà. Je ferme la parenthèse. Donc, j'ai dit deux grandes familles de pancréasites, pancréasites oedémateuses, gentilles, bénignes, pas de problème.

On la crasse, il n'y a pas de souci. À côté de ça, pancréasites graves, méchantes, nécrotico-hémorragiques, la nécrose, l'hémorragie, la digestion du pancréas qui est très intense, grave. Tellement grave qu'elle peut engager le pronostic vital du patient.

Retenez ces deux familles. Elles sont très importantes. Donc, vous devez connaître ces deux familles.

Oedémateuse, bénigne, pas de souci. Nécrotico-hémorragique, grave pour engager le pronostic vital du patient. Voilà.

C'est clair, c'est net. On passe à autre chose. Alors maintenant, vous êtes un grand médecin, vous savez pas mal de choses, vous savez ce que c'est que la physiopathologie, l'épidémiologie, l'anapathie.

Le patient, il s'attend pas à ça de votre part. Le patient s'attend à être pris en charge par vous en tant que praticien, en tant que médecin. Et là, en tant que praticien, en tant que médecin, j'ai essayé de vous faciliter la chose au maximum.

Il y a trois étapes primordiales et capitales pour ce que vous pensez à un pancréas IDQ. Vous êtes assis là, vous êtes de garde, c'est la nuit, 9h, 10h du soir, au CHU ou dans un hôpital

périphérique. Il y a un patient, une patiente qui a 35 ans, qui a enlevé sa vésicubilière il y a deux ans, qui vient consulter avec sa famille, épigastralgie.

Vous, vous connaissez déjà certaines notions de base dans votre tête, mais vous devez aller plus loin. Comment schématiser la chose ? Comment prendre en charge cette patiente-là ? Parce que n'oubliez pas, gardez toujours dans un point dans votre tête, c'est que le pancréas IDQ peut être grave. Donc, le pronostic vital peut être engagé dans certains pancréas IDQ.

Donc, il ne faut jamais prendre les choses à la légère. Il y a aussi certaines diagnostics différentielles que je vais vous citer par la suite, qui peuvent engager le pronostic vital du patient, de la patiente. Donc, comment est-ce que si dans ma tête, si dans un coin de ma tête en tant que médecin généraliste, je commence à raisonner, à penser à un pancréas IDQ, comment résoudre ce problème ? Alors, pour résoudre ce problème, il y a trois étapes toutes simples que je vous ai résumées.

Tout d'abord, poser le diagnostic. Avant toute chose, je dois être sûr de mon diagnostic. Est-ce que la patiente a un pancréas IDQ ou elle n'a pas un pancréas IDQ ? un, poser le diagnostic positif.

C'est un pancréas IDQ ? Ce n'est pas un pancréas IDQ. Ça, c'est un. Alors, si j'ai confirmé mon pancréas IDQ, la deuxième question qui se pose, vu que je connais maintenant mon anapathie, je sais qu'il y a deux grands types de pancréas IDQ.

Est-ce que mon pancréas IDQ est bénigne, gentille, vénéneuse ? Ou est-ce que c'est un pancréas IDQ grave qui peut engager le pronostic vital de la patiente ? Donc, la deuxième étape dans ma tête, après avoir posé le diagnostic positif, c'est évaluer la gravité de mon pancréas IDQ. Ça, c'est deux. D'accord.

Je suis sûr de mon diagnostic, le pancréas IDQ est vénéneux. Troisième des choses, maintenant, même si j'ai guéri ce premier épisode, est-ce qu'il n'y a pas une cause à cette pancréas IDQ ? Parce que si je guéris juste l'épisode et que la cause n'est pas guérie, n'est pas traitée, la patiente peut me refaire un autre épisode. Et qui sait, la prochaine fois, elle peut faire un épisode qui est encore plus grave.

Donc, je dois rechercher une cause à cette pancréas IDQ pour traiter la cause, pour proposer un traitement étiologique à la pancréas IDQ. D'accord. Donc, là, ce sont les trois étapes primordiales et capitales pour traiter un pancréas IDQ.

Un, est-ce que je suis un pancréas IDQ ? Je pose mon diagnostic positif. Deux, je sais que si je suis un pancréas IDQ, est-elle grave ou bénigne ? Trois, qu'est-ce qui a provoqué mon pancréas IDQ ? C'est un patient qui est en train de souffrir. Parce que si le patient, il a consulté un aveugle aux 10 heures du soir, c'est qu'il a un symptôme qui le dérange, c'est qu'il s'inquiète.

Et donc, n'oubliez pas que vous êtes face à un patient. Le raisonnement, vous le faites dans votre tête. Vous êtes déjà en train de faire travailler vos neurones, mais à côté, pensez à soulager le patient.

En faisant votre gymnastique cérébrale, n'oubliez pas de soulager le patient, de mettre en condition le patient de lui donner un antalgique. Parce que, première des choses, il faut penser au patient. C'est bien de penser, c'est bien de raisonner en tant qu'un grand médecin, grand praticien, mais c'est mieux de soulager le patient.

Parce que le patient, s'il a consulté, c'est parce qu'il est en train de souffrir. Voilà. Donc, si vous reprenez ces trois étapes, il n'y a plus de discussion.

Je pense que tout le reste viendra très, très simplement, très facilement. Diagnostic positif, gravité et étiologie. Alors, positif, je ne vais pas trop détailler la chose.

Donc, c'est une douleur abdominale qui a certaines caractéristiques, mais en règle générale, lorsque vous serez de garde aux urgences, toute douleur abdominale doit faire penser à un point de crédit dégueulasse. Et il y a ce réflexe-là. Pourquoi ? Parce que moi, en tant que praticien, j'ai eu des tableaux qui sont vraiment atypiques.

D'accord ? C'est vrai que souvent, elle est épigastrique, la douleur. Parfois, on a des douleurs dans l'hypoconde droit. Souvent, elle est transfixante vers le dos.

Parfois, elle n'est pas transfixante vers le dos. Souvent, telle chose. Donc, le tableau typique, oui, il est sémiologique, il est magnifique, il est joli.

On va le voir, d'ailleurs, dans la suite. Voilà. Donc, c'est le tableau qui est typique, mais il n'est pas toujours présent.

C'est pour ça qu'il faut garder en tête qu'à chaque fois que vous avez un patient qui est ensuite en urgence pour une douleur abdominale aiguë, pensez à une pancréatite aiguë. Maintenant, en tant que grand praticien, vous connaissez très bien votre cours, vous cherchez à décortiquer un petit peu. Vous faites un petit peu l'enquête.

Vous faites l'enquêteur, vous faites le policier, vous décortiquez. Ça, ce n'est pas seulement pour la pancréatite, ce n'est pas seulement pour la chirurgie. Donc, apprenez ça.

Il y a deux notions importantes en sémiologie chez un patient. Ça, ça va vous aider pour toute votre médecine, en fait. Vous avez un patient qui consulte pour un maître symptôme.

Si le patient vient consulter chez vous le soir, l'après-midi, s'il prend la peine de se déplacer dans votre cabinet ou s'il prend la peine de venir à l'hôpital, c'est qu'il a un symptôme qui le dérange. Et ce symptôme-là, on l'appelle le maître symptôme. Je ne sais pas si vous avez vu que c'est dans son nom en sémiologie.

Le maître symptôme, vous entend... Parce que là, vous n'êtes plus un médecin, vous êtes un enquêteur. Vous vous accrochez à ce maître symptôme. Vous prenez ce maître symptôme et vous le décortiquez.

Vous lui cherchez toutes les caractéristiques. Pourquoi ? Parce que rien qu'à l'interrogatoire, vous serez orienté vers un organe précis. Vous serez orienté vers une pathologie précise.

D'accord ? Donc, là, vous cherchez les caractéristiques sémiologiques. Ça, c'est de la sémiologie pure, tout simplement. Et ça, c'est juste que vous aurez de l'expérience.

Vous aurez pratiqué votre médecine. Parfois, rien qu'en voyant le patient rentrer dans votre bureau, vous posez déjà le diagnostic. Vous avez déjà deux ou trois diagnostics dans votre tête.

Vous avez un patient qui a les deux mains sur sa région épigastrique. Vous avez un patient qui est penché en avant. Vous avez un patient qui est autour de douleur.

Donc, juste, vous vous posez deux ou trois questions. Est-ce que la douleur est transfixante ? Est-ce que la douleur est radiée vers le dos ? Oui. Est-ce que vous avez mangé quelque chose de gras juste avant de venir ? Oui.

Donc, rien que faisant, en demandant ces deux ou trois choses et en regardant le patient, vous êtes déjà transfixante en arabe. la douleur est transfixante. Tout simplement.

Ça serait un peu une douleur transfixante parce qu'elle traverse l'abdomen. C'est une douleur en poignard en fait. C'est comme si un poignard traversait la région épigastrique et qu'il allait vers le dos.

C'est dû à l'anatomie. On a dit que le pancréas est en contact direct avec le rachis et avec la haut parce qu'il est très postérieur et donc forcément c'est pour ça qu'on a cette douleur. Voilà.

Donc, ça c'est de la symbiologie. On va avancer parce qu'il ne reste plus que vingt minutes en fait ensemble. Donc, je vais avancer.

Les signes associés sont inconstants. Un, ils sont non spécifiques. Deux, nausée, ce n'est pas spécifique à la pancréasie.

Vomissement, ce n'est pas spécifique. Occlusion fonctionnelle, oui, c'est possible parce que vous avez une inflammation qui peut être très intense du pancréas, vous avez des onges intestinales qui passent juste à côté. L'ongie intestinale, lorsqu'elle va toucher le foyer inflammatoire, elle va se contracter.

Elle va avoir ce qu'on appelle un ilus reflex et en se contractant, ça peut provoquer une ilus fonctionnelle. Donc, ilus fonctionnelle, l'intestin en lui-même il est intact mais je pense que le cours des occlusions, vous allez la voir je pense avec professeur Lousi ou là avec un autre

confrère, il y a ce qu'on appelle les occlusions reflex, les occlusions inflammatoires. Donc là, c'est une occlusion reflex, c'est un ilus reflex, une occlusion qui est fonctionnelle.

Les signes généraux, ils sont importants à rechercher parce que s'ils sont absents, ça sous-entend déjà que la pancréatite n'est pas grave, ça sous-entend qu'elle est bénigne et malheureusement, s'ils sont présents, ça sous-entend que la pancréatite, elle est sévère, elle est grave. Ils sont variables, on peut avoir un pot qui est filant, qui est rapide, on peut avoir une hypotension. Dans les cas qui sont les plus graves, on peut avoir un état de choc, quasiment.

Si vous avez un état de choc, c'est que la pancréatite est extrêmement grave et ce sont des patients qui sont normalement admis rapidement en réanimation parce qu'ils sont déjà en état de choc sévère sur pancréatite aiguë. Signes physiques, il y a une notion à retenir dans les signes physiques, c'est qu'il y a une discordance en fait. Vous avez un patient qui a très, très mal, qui se tord de douleur, très, très mal, vous déshabillez votre patient, vous posez votre main, vous vous attendez à avoir une défense, une contracture comme dans la péritonite par exemple.

Non, rien. Quasiment une petite sensibilité, un petit météorisme. Une défense, elle est très, très rare.

Elle est très, très rare en matière de pancréatite aiguë. Donc souvent, cette notion de discordance en fait, entre une douleur qui est très intense et un examen clinique qui est pauvre, fait évoquer, il est en faveur de la pancréatite aiguë. D'accord ? Alors, vous avez des signes qui sont historiques.

Bon, c'est juste pour faire joli, pour montrer des images dans le cours. Les signes de Grès-Turner qui est des échymoses d'efflants. Les signes de Cullen, échymoses en périombélicale.

Ce sont des des inflammations qui sont retrouvées lorsque vous avez des pancréatites qui sont très, très sévères. Mais ce sont des signes qui sont historiques, qui sont très inconstants. Alors, vous avez est-ce que la position chez un fusil est retrouvée uniquement en cas de pancréatite aiguë dans les autres pathologies pancréatiques ? Elles sont retrouvées lorsque vous avez une douleur aiguë du pancréas.

Dans le cancer du pancréas, vous ne l'avez pas, par exemple. Dans une pancréatite chronique, vous ne l'avez pas. Dans l'équice du pancréas, vous ne l'avez pas.

Elle est souvent retrouvée dans la pancréatite qui est aiguë et il est dû à l'inflammation aiguë du pancréas. La douleur, elle est tellement aiguë et se revient de façon brutale chez le patient que le patient est obligé de... Parce que lorsqu'on a mal, c'est un réflexe. On recherche toujours une position en Tadjik et en recherchant les positions en Tadjik, on se rend compte qu'en se positionnant en avant, en se penchant en avant, ça soulage la douleur.

Et donc forcément, ça évoque fortement une pancréatite aiguë. D'accord ? Avant, on l'appelait

dans les bouquins de l'époque coloniale, dans les bouquins qui sont très anciens, on l'appelait la position du Mahometan. Le Mahometan, c'est le musulman.

Parce que, soi-disant, ça ressemble à la position de Mnekensleu quand on fait notre prière, mais ça a été supprimé parce que ça sous-entendait des préjugés racistes. Et donc, vous avez pu retrouver ce terme-là, ce terme du Mahometan. La position du Mahometan, ça n'existe plus.

D'accord ? On l'a remplacée par chien de fusil. Voilà. Donc, discordance entre... ou dissociation entre signe fonctionnel et signe physique fait évoquer le diagnostic de pancréatite aiguë.

Douleur très intense, examen physique, pauvre, pour que ça sous-entend, pancréatite aiguë. On avance. Voilà.

Donc, la question qui se pose et que je peux vous poser, vous avez un patient qui a un tableau typique qui évoque une pancréatite aiguë, douleur transfixante, épigastrique intense après avoir pris un repas copieux. Quel est l'examen complémentaire que vous allez demander ? Ou donc, quel est l'examen complémentaire que vous allez demander ? Vous me cochez la lipazémie et vous la cochez dans votre tête. Vous la garderez en tête pour toujours.

D'accord ? Voilà. Donc, c'est la lipazémie. Gardez-la en tête dès maintenant.

Lipazémie. Vous pensez à la pancréatite, ne demandez rien du tout. Ne demandez pas un scanner cérébral, ne demandez pas une radio du genou.

Demandez une lipazémie. D'accord ? Cochez-la, l'examen. Vous allez tous la cocher, j'en suis sûr certain, parce que je vous la poserai pour l'examen.

Mais si vous la cochez, je serai content parce que je vais me dire dans ma tête qu'il y a un objectif principal dans mon cours qui a été atteint, qui a été saisi par la majorité de mes étudiants, c'est que lorsque vous pensez à la pancréatite et vue, ne me demandez pas un groupage ou autre chose, demandez une lipazémie. Si vous cochez juste lipazémie, c'est suffisant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je les ai déjà détaillés dans le cours audio sonorisé que je vous ai mis.

Donc, lipazémie, le taux qui fait retenir le diagnostic, là aussi, parce que je peux vous la poser comme question, c'est trois fois la normale. D'accord ? Non, le taux n'est pas proportionnel. On me pose la question est-ce qu'il est proportionnel par rapport à la gravité ? Non, je peux avoir des lipazémies qui sont à 2000 dans la pancréatite qui sont bénignes.

Donc, ça, ça ne vous entend pas que plus la lipazémie elle est augmentée, plus la pancréatite elle est grave. Donc, ce n'est pas une notion qui est importante. D'accord ? Donc, lipazémie, déjà, un, pour retenir le diagnostic, vous faites la lipazémie et elle doit être à trois fois, à supérieur à trois fois la normale.

Donc, lorsque je pense que vous avez déjà commencé à passer dans les services et chez vos patients dans le service, soyez curieux. Moi, quand j'étais en troisième année, la première, l'une des premières choses que j'ai commencé à apprendre et même dans mon entourage familial, c'est que je prenais les bilans. Je m'amusais à voir les bilans et à interpréter un petit peu les bilans.

Faites ce petit jeu-là donc, entre vous, là, dans les dossiers des patients que vous avez et même si vous êtes en chirurgie ou là, vous êtes dans des services qui ne sont pas spécifiquement médicaux, apprenez à lire une NFS, apprenez à lire une liposémie, à lire un bilan épatétique, demandez au résident qui est à côté de vous, demandez au prof dans la visite s'il est sympa, bien sûr. Donc, mais apprenez à lire vos bilans, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de bilans qu'on peut demander mais il y a certains bilans qui sont les plus fréquents. Une NFS, par exemple, elle est facile à interpréter et elle est très fréquente.

Chez quasiment tous les patients qui sont hospitalisés, quelle que soit la pathologie, vous trouverez une NFS. Vous devez apprendre à lire une NFS, c'est ça, c'est simple. Les globules blancs, juste les trois notions de base, je ne parle pas des détails, les globules blancs et plaquettes, ce sont des choses qui sont basiques.

La liposémie, c'est encore plus simple. Lorsque vous aurez les résultats de la liposémie, vous aurez juste à côté des valeurs normales, souvent entre 0 et 60, entre 0 et 50, entre 0 et 40. Et donc, pour retenir une pancréasité aiguë, le taux doit être supérieur à trois fois la normale.

Si je vous donne dans l'examen, chez notre patient, nous avons réalisé une liposémie dont le taux normal ne devrait pas dépasser 60 unités par litre. Chez notre patient, nous avons retrouvé un taux de 200. Non ? Oui.

60 fois 3, 180. 200 supérieur à 180, c'est une pancréasité aiguë. Chez notre patient, nous avons retrouvé 110 ou 100 par rapport à une normale de 60.

Non, ce n'est pas supérieur à trois fois la normale. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des colic épasiques, on peut avoir des litiases vésiculaires simples qui peuvent entraîner une petite augmentation non spécifique de la liposémie. Parce que la lipase n'est pas produite que par la pancréase.

Donc il y a certaines choses qui font augmenter la liposémie mais de façon non spécifique. D'accord ? Est-ce que toute douleur abdominale aiguë, on demande systématiquement la liposémie ? Dans certains centres hospitaliers, oui, la liposémie fait partie du bilan classique. Comme on demande une radiographie thoracique, une NFS, on demande également la liposémie.

Par exemple, lorsque j'étais en stage en Belgique, oui, on demandait la liposémie systématiquement. Chez toute douleur abdominale, la liposémie, c'est même médico-légale.

Pourquoi ? Parce que supposons que vous n'avez pas demandé votre liposémie, que vous pensez, par exemple, je dis une bêtise, je peux dire une bêtise, pensez à une péritonite, que vous opérez le patient, c'est une faute médico-légale, c'est une faute médicale.

Une pancréasite aiguë ne doit pas être opérée en urgence, sauf dans des cas exceptionnels qu'on verra dans le traitement. D'accord ? Si vous opérez une pancréasite bénigne par une laparotomie, vous infectez, vous surinfectez l'inflammation de la pancréasite et vous pouvez entraîner le décès du patient. D'accord ? Dans certains centres hospitaliers, la liposémie peut faire partie du bilan systématique d'un abdomen aigu.

D'accord ? Je ne peux pas répondre de façon tranchée, de façon formelle à ce qu'elle fait, elle est systématique, mais le caractère systématique dépend des équipes, au fait. C'est comme ça que je répondrai à votre question. D'accord ? Ça dépend des centres hospitaliers.

Moi, je vous dis juste qu'une liposémie à 3 fois la normale, si vous pensez à une pancréasite, demandez la liposémie en premier et si elle est supérieure à 3 fois la normale, c'est une pancréasite aiguë. Voilà. Ce sont deux notions qui sont importantes.

Voilà. Donc, douleur abdominale plus lipase ou amylase supérieure à 3 fois la normale, pancréasite aiguë, pas de discussion. Donc là, vous avez retenu votre diagnostic, il n'y a pas de souci.

Excusez-moi, je reprends mon souffle un petit moment. Maintenant, que faire ? Vous le savez déjà, on l'a déjà vu tout à l'heure. Vous avez retenu votre pancréasite aiguë, j'évalue la gravité.

Est-elle bénigne ? Est-elle grave ? C'est la question que je dois me poser secondairement. Pour cela, il y a deux scores. Les scores, ce sont des choses objectives sur lesquelles je me base pour affirmer que j'ai affaire à une pancréasite bénigne ou j'ai affaire à une pancréasite grave.

Il y a un score qui se base sur le scanner, sur l'imagerie qui est le score de Balthazar. Il y a un score qui est basé sur des données cliniques et biologiques qui est le score de Ronson. Le score de Ronson, il est long, le score de Ronson.

Il y a onze critères à retenir avec plein de chiffres et plein de trucs. Je ne m'amuserai pas à poser trop de questions là-dessus. Vous l'avez, ce sont des chiffres à connaître, à connaître, à savoir, tout simplement.

Mais bon, à l'admission, c'est l'âge, la leucocytose, la glycémie, l'EDF et l'ASAT que vous avez sur le tableau. Maintenant, pour chaque item que vous avez, vous avez un point. Donc, si j'ai un ASAT supérieur à 50-50, j'ai un point.

Si j'ai des leucocytes à 17 000, un point. Si j'ai une calcémie inférieure à 2, j'ai un point, etc. Plus le nombre de points augmente, plus la pancréasite est grave.

C'est ce qu'on appelle le score de Ronson. Plus vous avez un score, plus vous avez deux points, plus le pronostic est fâché, plus la pancréasite est grave. Le score de Balthazar est le plus utilisé.

Pour vous dire les choses franchement, concrètement, le Ronson, on ne l'utilise pas beaucoup au service. Le plus souvent, ce qu'on utilise, c'est le scanner. Pourquoi? Parce qu'on a des clichés, on a des images devant nous et on peut évoluer directement la gravité du pancréasite.

Donc, pour résumer, stade A, pancréas normal. Stade B, une augmentation de la taille du pancréas. Stade C, infiltration de la graisse péri-pancréatide.

Stade D, une coulée de nécrose. Et stade E, plusieurs coulées de nécrose. Si la patiente est enceinte, on fait une IRM.

Donc, l'IRM peut nous donner les mêmes images par rapport au pancréas. L'IRM, on peut la faire sur la femme enceinte, il n'y a pas de soucis. Donc, stade E, on va avoir quasiment les mêmes images.

On fait le scanner parce qu'il est moins cher tout simplement et parce que les images sont plus simples à interpréter. Pancréas pour évoluer la gravité est contre-indiqué. Donc, je réponds à votre question.

On peut faire une IRM. L'IRM, elle est faisable. L'IRM va donner les mêmes images que le pancréas, mais elle est plus chère que le scanner et elle est moins disponible que le scanner.

C'est pour ça que on se vend sur le scanner. En plus, le scanner a été... La description de Balthazar, elle a été faite initialement sur le scanner. Maintenant, ce qu'on a sur le scanner, il est superposable à l'IRM.

On peut le faire. On peut faire l'IRM chez la femme qui est enceinte pour régler le problème de la femme enceinte. Alors, maintenant, diagnostic différentiel, il est strictement anatomique.

Si vous connaissez l'anatomie, vous pouvez répondre à cette question à part, bien sûr, l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde n'est pas épigastrique. On n'a pas de myocarde dans la région épigastrique, mais on a ce qu'on appelle les manifestations, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde à manifestation digestive.

Donc, il peut se manifester par des douleurs épigastriques, mais ça restera quand même. Pour tous les autres organes, crise d'ulcère, gastro-diurnale parce que l'estomac, il se projette dans la région épigastrique. Gastrite aiguë, c'est l'estomac.

Mésentère parce que vous avez les vaisseaux mésentériques qui passent derrière plus devant le pancréas. C'est donc forcément l'infarctus du mésentère. Abscès du foie gauche, vous avez le foie gauche qui se projette dans la région épigastrique.

Péritonite aiguë parce que vous allez avoir une inflammation souvent due à une perforation gastrique et là aussi, ça se projette dans la région épigastrique. Donc forcément, toutes les propositions, toutes les étiologies, elles se fondent sur l'épigastrie, sur la douleur épigastrique aiguë. Alors, troisième étape dans la prise en charge de notre patient, c'est le diagnostic étiologique.

Donc, un, sur le sujet du pancréas, deux, est-il grave ? Trois, quelle est sa cause ? Pour éviter les récides. Donc là, je vais passer assez vite. Il faut connaître les causes pour les rechercher, tout simplement.

L'interrogatoire, l'âge, parce que, comme vous le savez, l'anesthésie biliaire est la plus fréquente chez la femme entre 30 et 50 ans, la femme jeune. Antécédent biliaire, est-ce qu'elle a déjà été opérée pour sa vésicule biliaire ? Est-ce qu'il prend de l'alcoolisme ? Est-ce qu'il prend un médicament ? Est-ce qu'il a été opéré de sa vésicule ? Est-ce qu'il a eu une endoscopie, etc. Il faut rechercher ce qu'on appelle les facteurs de risque qui sont liés aux étiologies qu'on a citées tout à l'heure.

Bilan biologique, il n'y a pas de bilan biologique systématique offert en matière de recherche étiologique. C'est du cas par cas. Si je pense à l'hypercalcémie, par exemple, je ferais un bilan phosphocalcique.

Si je pense à l'hyperlipidémie, je ferais un bilan lipidique. Si je pense à l'hypertension, je ferais un bilan immunologique, etc. Donc, le bilan, il n'y a pas de bilan systématique à faire.

Je ne vais pas vous poser la question quel est le bilan systématique à faire pour la recherche d'une étiologie. Il n'y a pas de bilan systématique à faire. C'est du cas par cas et ça dépend de l'orientation diagnostique chez vos patients tout simplement.

Par exemple, en matière d'étiologie biliaire, l'étiologie biliaire, l'échographie hépatobiliaire est suffisante. Si vous faites une échographie, vous pouvez retrouver un calcul dans la vésicule biliaire et vous êtes déjà orienté par rapport à l'origine lithiasique ou à l'origine biliaire de votre concrétité aiguë. Parfois, si l'échographie n'est pas suffisante, par exemple, chez les patients qui ont déjà enlevé la vésicule biliaire et qui ont juste une voie biliaire qui est en place ou qui ont peut-être un calcul dans l'enveloppe principale, l'enveloppe principale n'est pas très bien explorée, notamment chez les patients qui sont obèses ou chez les patients qui ont beaucoup de gaz qui ont des colopathies.

Dans ces cas-là, on peut s'aider par d'autres examens complémentaires, notamment la bilirrubinémie ou l'échodoppler. L'échodoppler, c'est à la fois pour le diagnostic et pour le traitement. C'est pour les deux parce qu'on peut faire ce qu'on appelle la sphinctérotomie.

Ça, je suppose qu'on l'avait déjà eu dans le cours de la lithiase biliaire avec François Braquiat. Donc, on commence par l'échographie hépatobiliaire et si on est coincé, on peut aller plus loin.

Alors, principales étiologies, pour moi, reprenez juste que la cause la plus fréquente au Maroc, c'est la lithiase biliaire.

Retenez juste ça. Ça me suffit largement. Le terrain, vous le connaissez déjà.

Vous l'avez eu dans le cours avec François Braquiat. La cause, vous la savez, vous la connaissez. C'est un calcul qui a migré, qui s'est bloqué dans l'ampoule de Vater, qui a bloqué le canal de Wirsung et qui a provoqué l'inflammation du pancréas et la pancréatite aiguë.

L'alcoolisme, donc, il est souvent chez un patient qui a été intoxiqué pendant des années. Ce sont les grands alcooliques qui ont bu et rebu et rebu et qui, un jour, vont faire une crise de pancréatite aiguë dû à leur alcoolisme qui est chronique. Donc, rarement chez un patient qui, un jour, a eu un petit coup de folie dans la tête et qui a bu de l'alcool et qui a fait sa pancréatite.

Donc, souvent, ce sont des alcooliques qui sont chroniques et qui ont bu plus que d'habitude et qui ont fait leur pancréatite aiguë. Pancréatite post-opératoire, oui, parce qu'on peut être ramené à faire des gestes sur l'avabilité principale. Ça aussi, je vais vous revenir un petit peu au cours de la lithiase biliaire avec François-Paul Riad, parce qu'on a un calcul dans l'avabilité principale, on ouvre, on fait ce qu'on appelle des colédocotomies, on ouvre l'avabilité principale, on met des sondes dans l'avabilité principale et en mettant ces sondes-là, on peut irriter un petit peu l'ampoule de Vater, on peut la bloquer parfois, et en la bloquant, en l'irritant, ça peut provoquer une inflammation du pancréas.

Donc, c'est la pancréatite aiguë post-opératoire. Sphinctérotomie, la même chose, on peut être ramené parce que, parfois, on a des calculs dans l'avabilité principale, dans le bas colédoc, notamment, on fait une sphinctérotomie endoscopique, on introduit un endoscope dans le duodenum, on ouvre l'ampoule de Vater en l'ouvrant, on va inflammer l'ampoule de Vater et en l'inflammant, ça peut provoquer des pancréatites. Pancréatites post-traumatiques, là aussi, j'ai un pancréas qui a été traumatisé, qui va s'inflammer, qui a été comprimé contre le rachis, il va s'inflammer.

Donc, en avance, parce qu'on arrive quasiment au bout de notre sociologie médicale, je passe. Les complications pour les pancréatites bénignes, pas de complications, pour les pancréatites graves complications. Quel délai pour avoir une pancréatite aiguë post-opératoire ? Souvent, c'est dans l'immédiat, c'est dans les suites immédiates parce que c'est le geste chirurgical qui a provoqué la pancréatite aiguë.

Donc, c'est dans les suites immédiates, c'est dans la semaine. On peut avoir des formes qui sont retardées, qui sont rares, mais le plus souvent, c'est dans les suites immédiates, dans la semaine qui suit le geste thérapeutique. Voilà.

Donc, pancréatites bénignes, pas de complications, pancréatites graves complications. Quelques complications ? Surinfection de coulée de nécrose. Donc, reprenez cette complication-là, c'est la

première, je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas de soucis à répéter ça, c'est la première cause de mortalité en matière de pancréatite aiguë.

Quelle est la cause ? La première cause pour laquelle décède un patient qui a une pancréatite aiguë, c'est lorsqu'il va surinfecter sa coulée de nécrose. D'accord ? C'est la première cause de mortalité. À côté, on a les complications métaboliques que votre ami a citées tout à l'heure.

Il m'a posé la question par rapport au diabète. Le diabète fait partie des complications métaboliques qui sont dues à la pancréatite aiguë. Un pancréatite aiguë qui détruit complètement la pancréatite aiguë peut faire un diabète secondaire.

Les focuses du pancréas et les abcès du pancréas, les fissures, on va les voir par la suite. Donc ça, c'est un focus du pancréas. La flèche, en fait, elle montre tout ce qui reste du pancréas.

Tout ce que vous voyez à côté, c'est un focus du pancréas. Et comme je l'ai dit dans le cours qui est sonorisé, le focus du pancréas va s'enchâsser, s'encaster dans l'arrière-cavité des épiploques, dans la bourse mentale. C'est un vieux terme que vous avez vu en première année, c'est loin déjà.

C'est entre la face postérieure de l'estomac, que vous voyez avec la petite étoile sur le scanner, et la face antérieure du pancréas que vous voyez avec la flèche. Entre les deux, vous allez avoir ce qu'on appelle un focus du pancréas. Focus parce qu'il n'a pas de paroi propre.

Il est délimité par les organes de voisinage de l'arrière-cavité des épiploques. D'accord ? Donc il est un contenu vraiment hypodent. C'est un contenu vraiment liquidien.

C'est ce qu'on appelle un focus du pancréas. Les petites bulles que vous voyez, ce sont des bulles d'air qui correspondent à une surinfection d'une coulée de nécrose. Elles sont extrêmement graves.

L'air sous-entend que c'est une surinfection d'une coulée de nécrose. Si on trouve à la tête d'une pancréatite grave, est-ce qu'il faut commencer une antibioprophylaxie pour éviter la surinfection ? On va revenir au traitement. Les antibiotiques ne sont pas systématiques, mais par mesure de précaution, le plus souvent en réanimation, dans des équipes de chirurgie, on fait une antibioprophylaxie.

Mais ils ne sont pas systématiques. Dans le protocole classique, on n'a pas d'antibiotiques d'emblée pour éviter la surinfection. Pour parler de traitement, ça me permet de revenir un petit peu sur le traitement, d'introduire le traitement.

Comme dans toute pathologie, il y a des traitements symptomatiques qui vont traiter le symptôme que le patient présente. Il y a des traitements étiologiques qui vont traiter la cause de la maladie. Et dans ce cours spécifique, traitement des complications.

Symptomatiques, c'est la base. Toute pancréatite sera hospitalisée, parce qu'elle peut être potentiellement grave. Si vous posez une diagnose de pancréatite aiguë, vous hospitalisez le patient, ça c'est un.

Deuxième des choses, vous mettez au repos digestif. Pourquoi? Parce que si le patient ne mange pas, le pancréas ne va plus fabriquer d'enzymes, ne va plus sécréter d'enzymes. Et donc ce pancréas aura le temps de cicatriser.

Donc repos digestif. Et puis trois, le patient a mal. Il a consulté parce qu'il a une douleur.

Donc vous le mettez sous antalgique. D'accord, plus ou moins, vous commencez par les paliers. Vous commencez par le paracétamol.

Puis vous allez en augmentant la dose, en changeant la molécule, pour aller dans les cas qui sont le plus extrêmes, vers la morphine. Bien, puisque le patient ne va pas manger, il faut le perfuser. Il faut lui donner des apports hydroélectrolytiques pour éviter qu'il se déshydrate.

D'accord. L'ascende, l'asthme n'est pas systématique. C'est sauf si le patient a des vomissements qui sont très amodants, répétitifs.

Réalimentation, il doit être progressif. Souvent, on ne garde pas le patient à jeûner de façon prolongée. Pourquoi? Parce qu'il va souffrir de la dénutrition, de la déshydratation, même s'il reçoit des apports hydroélectrolytiques.

Donc rien ne remplace l'alimentation normale. Et donc, normalement, si le patient, si la douleur régresse au bout de 48 heures, on recommence, on commence à faire alimenter les patients progressives. Pancréasites graves, ce sont des pancréasites qui sont en réanimation.

Donc, à côté de ce qu'on vient de citer, il faudra traiter les autres défaillances viscérales. Parce que ce sont des patients qui font des états de choc systémique. Et donc, il faut traiter, il faut les intuber, il faut les ventiler, il faut faire plein de choses, plein de mesures de réanimation qui sont extrêmement graves.

Et ce sont des patients qui ont, malheureusement, des pronostics qui sont extrêmement réservés. Mettons le traitement étiologique. Ça, c'était le traitement symptomatique.

Traitement étiologique, comme on l'a vu, on va surtout aborder les pancréasites d'origine biliaire. Lorsqu'on a les pancréasites d'origine biliaire, la patiente, elle est admise, elle est hospitalisée. On refroidit, on pratique.

Je vous parle en pratique. Ce qu'on fait en pratique, elle est hospitalisée pendant deux, trois jours. On refroidit sa pancréasite.

Fin de la première semaine, si la douleur regresse, on la programme pour faire une colitis

tectume. Idéalement, pour avoir un stéioscope. D'accord? Pancréasite nécrotico-hémorragique, qui est plus grave.

Là, il faut bien refroidir la patiente. D'accord? Donc, la patiente, elle est hospitalisée, elle est mise au repos digestif, sous ontalgique. On attend quatre à six semaines.

Donc, si la douleur regresse, au bout d'une semaine, une dizaine de jours, elle peut sortir. La patiente peut sortir sous traitement, sous régime. Et puis, à la fin de la quatrième semaine, on la reconvoque pour faire un bilan.

On refait un scanner, on la rebilane pour rechercher d'éventuelles complications. Si la patiente n'a pas de complications, dans ce cas-là, on la programme pour faire une colitis tectume. D'accord? La nécrosectomie en urgence, elle est exceptionnelle.

Et souvent, lorsqu'on la réalise, c'est que le pronostic, il est fâcheux, on ne peut pas faire attention à ces patients-là. Est-ce que pendant les quatre semaines, non, il ne reste pas à jeun, non. Le jeun, c'est la douleur qui dicte le jeun, en fait.

Le repos digestif, c'est pendant 48 heures, 72 heures maximum. D'accord? Si la douleur, elle regresse, on commence à réalimenter le patient de façon progressive. Parce que si on les laisse à jeun pendant quatre semaines, le patient, il va mourir de dénutrition.

C'est impossible. D'accord? Donc, il ne reste pas à jeun pendant quatre à six semaines, il reste à jeun juste trois, quatre jours maximum le temps de faire refroidir un petit peu la pancréatite. Voilà, donc si le patient, il a un calcul associé dans l'avobillièrè principale On ne va pas rédéfinir, non, parce qu'entre temps, la pancréatite est refroidie, le pancréas entre temps, il a cicatrisé.

D'accord, ça a refroidi parce qu'on a des entalgies, qu'on a mis complètement au repos digestif, rien que ces mesures là font que ça se calme. Mais parfois, chez certains patients, malheureusement, le fait de réalimenter reproduit la douleur. C'est un certain nombre de patients, pas tous les patients, 30 à 40% des patients ont ce problème là, surtout dans les pancréatites qui sont graves.

Et chez ces patients qui malheureusement ont ce problème là, on est obligé de faire une nutrition, ce qu'on appelle une nutrition parentérale. Ils vont avoir une alimentation par voie intraveineuse. Mais ce ne sont pas des cas qui sont fréquents.

Souvent, lorsqu'on met au repos digestif, le pancréas, il cicatrise, il se refroidit. Et heureusement d'ailleurs, on commence à réalimenter les patients. Lorsqu'on a un calcul, on a deux sortes de traitements.

Lorsqu'on a un calcul dans l'avobillièrè principale, c'est-à-dire qu'on fait une sphincterotomie endoscopique. Et si elle n'est pas disponible, on opère les patients. On fait une extraction des calculs, on fait une dérivation biliaire pour enlever le calcul biliaire.

Pour les autres étiologies, ça dépendra de la cause. Alcoolique, sévrage alcoolique, médicamenteuse, etc. Les complications lorsque j'ai une surinfection, antibiothérapie.

Les phoquistes, c'est la règle des 6 dont je vous ai parlé dans le cours sonorisé. On ne les touche pas. On attend 6 semaines, plus de 6 cm, plus de 6 semaines, on les dérive.

En conclusion, pancréasite. Il y a des mots clés dans ce cours. Vous ne pouvez pas tout connaître dans le cours, mais il y a des choses que vous devez connaître.

Elles sont importantes. Vous devez savoir que la pancréasite, souvent, est bénigne. Parfois, elle est grave.

Parfois, elle peut tuer le patient. Parfois, elle peut engager le principe vital du patient. Ça, c'est un.

Au Maroc, la pancréasite est plus souvent due à l'ithias biliaire. Deuxième notion qui est très importante. Troisième notion qui est importante, c'est que c'est une prise en charge multidisciplinaire.

Vous voyez très bien qu'on n'opère pas tous les patients d'emblée. Il y a des patients qui peuvent aller 4 à 6 semaines. Il y a des patients qui vont en réanimation.

Donc, c'est une prise en charge qui est médico-chirurgicale, qui fait intervenir les spécialités médicales et les chirurgiens. Le plus important, c'est la prévention. Donc, si on s'amuse à enlever tous les patients, à enlever tous les vésicules chez les patients qui ont des lithias biliaires, on n'aurait pas de pancréasite aiguë.

Si les patients arrêtaient de boire, ils n'auraient pas de pancréasite aiguë. Si on traitait toutes les causes qui ont traité le pancréasite aiguë, il n'y aurait plus de pancréasite aiguë. Le pancréasite aiguë, au fait, c'est une conséquence à d'autres choses.

C'est une maladie, oui, certes. C'est une pathologie, certes. Mais c'est une pathologie qui est la conséquence d'autres thérapies.

D'un thérapeute qui est présent. Et si on traite le thérapeute, il n'y aura pas de pancréasite. Donc, professeur, est-ce que la recherche de pancréasite est systématique dans toute lithiologie biliaire? Oui, souvent, chez les patients qui sont programmés pour pancréasite, pour lithiase biliaire, par exemple, dans le bilan qu'on réalise chez ces patients-là, juste avant de les opérer, on demande du lipazémie.

On demande la MFS, on demande un groupage, on fait un ECG, un radiothorax et on demande du lipazémie. Le lipazémie fait partie du bilan systématique de ces patients qu'on va opérer pour une lithiase biliaire ou un calcul biliaire. Voilà, donc je vous donne une ou deux petites minutes.

Vous avez d'autres questions? Parce qu'on a débordé un petit peu sur la plage horaire. Je ne sais pas si tout est clair. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de reprogrammer notre séance interactive pour les deux cours qui restent.

Les tumeurs hépatiques et les tumeurs biliaires. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Ce sont des cours qui sont très fréquents.

Des pathologies qui sont extrêmement fréquentes. Vous serez forcément confrontés à ces maladies. Je vous le dis.

Soit dans votre entourage, soit en tant que praticien. Vous verrez des hernies. Vous aurez des interrogations par rapport aux hernies.

Vous verrez des patients qui ont des lithiases biliaires. Vous verrez des patients qui ont des pancréas itégués. Et comme vous avez vu dans ces cours-là, il y a des messages clés.

Il y a des choses clés que vous devez connaître. Il y a des notions de base que vous devez connaître. Même lorsque je vous pose des questions, l'examen, ce ne sont pas des questions techniques.

Ce sont des questions sur des notions adaptées à votre cursus et adaptées à votre niveau. Tout simplement. Sur ce, très bon courage et à la prochaine.

Inch'Allah.